Heinz Körner · Theaterwall 62 · 26122 Oldenburg

Weser-Ems Gesundheitskasse · Leistungszentrum Hilfsmittel
Stau 35 · 26122 Oldenburg

Oldenburg, 22. Mai 2026 · Versichertennummer WEK-418-77-920

Antrag auf Hilfsmittelversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage einen Elektrorollstuhl, mit dem ich im Haus und in der Nähe meiner Wohnung zurechtkomme. Die Verordnung von Frau Dr. Stahlmann vom 16. Mai und das Angebot der RehaTechnik Albrecht vom 20. Mai lege ich bei. Welches Gerät es am Ende ist, würde ich gern mit Ihnen und dem Sanitätshaus nach einem Fahrversuch entscheiden. Wichtig sind mir eine Steuerung rechts, genügend Halt beim Sitzen und ein Stuhl, den ich durch die hintere Haustür bekomme.

Seit dem Sturz vor der Apotheke am 3. Mai habe ich den Weg dorthin nicht mehr allein geschafft. Mit dem Rollator kann ich auf einem glatten Flur mit einer Person daneben eine Strecke gehen. Auf dem Gehweg, an abgesenkten Bordsteinen und beim Öffnen schwerer Türen geht das anders. Ich habe einen einfachen Rollstuhl ausprobiert. Beim Schieben mit den Armen komme ich aus der Richtung, und nach kurzer Zeit tut die rechte Schulter weh.

Mein Hausarzt und die Apotheke liegen am üblichen Fußweg durch die Nachbarschaft. Ich möchte wenigstens diese Wege wieder selbst erledigen, sobald ich den Stuhl sicher bedienen kann. Bei einer Erprobung im Hof konnte ich nach einer Einweisung wenden und anhalten. Ob ich alleine sicher rückwärts aus der Abstellnische komme, ist noch offen. Der Platz für das Laden und der Zugang zur Straße müssen vor der Lieferung mit der Hausverwaltung besprochen werden.

Bitte geben Sie mir Bescheid, welche Unterlagen oder welche weitere Erprobung Sie für die Entscheidung brauchen. Wenn Sie ein anderes Gerät vorschlagen, bitte ich um einen Versuch mit diesem Gerät im Haus und im Hof.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Körner

Beigefügt sind die Verordnung vom 16. Mai, der Facharztbericht vom 17. Mai und der Kostenvoranschlag vom 20. Mai 2026.

Eingangsvermerk Leistungszentrum Hilfsmittel · am 22. Mai 2026 in der Geschäftsstelle abgegeben und zum Vorgang HM-2026-7714-E erfasst.

Hausarztpraxis Dr. med. Eva Stahlmann
Lange Straße 44 · 26122 Oldenburg
Telefon 0441 21893 · Telefax 0441 21894 · praxis@stahlmann.de
Dr. med. Eva Stahlmann · Fachärztin für Allgemeinmedizin
ÜBERWEISUNG

Hausarztpraxis Dr. med. Eva Stahlmann · Lange Straße 44 · 26122 Oldenburg

Facharztpraxis Dr. med. Malte Radtke
Nadorster Straße 91
26123 Oldenburg

Datum	8. Mai 2026
Aktenzeichen	Patient 77142 / Versicherter WEK-418-77-920
Bearbeitung	Dr. med. Eva Stahlmann

Prüfung von Gehleistung, Sturzgefährdung und Hilfsmittelbedarf

Sehr geehrter Herr Kollege Radtke,

1. Diagnosen

Lumbale Spinalkanalstenose L3 bis L5; diabetische Polyneuropathie beider Füße; Zustand nach Hüfttotalendoprothese links 2022; Herzinsuffizienz NYHA II bis III; Schulterarthrose rechts; wiederholte Stürze.

2. Anlass

Herr Körner berichtet über zunehmende Gangunsicherheit und zwei aktuelle Stürze am 28. April im Hausflur sowie am 3. Mai vor der Apotheke. Der bisher genutzte Rollator und die Unterarmgehstütze ermöglichen nach meiner Beobachtung keine sichere selbstständige Mobilität außerhalb weniger Schritte in der Wohnung.

3. Fragestellung

Bitte beurteilen Sie Gehstrecke, Stand- und Wendestabilität, Armkraft für einen manuellen Rollstuhl, kardiale Belastbarkeit und die Eignung für einen kompakten Elektrorollstuhl. Benötigt wird eine funktionelle Aussage für Wohnung, Hauseingang und Nahbereich. Bitte berücksichtigen Sie Türbreiten und Schwellen aus dem beigefügten Wohnungsbogen.

4. Anlagen

Medikamentenplan vom 4. Mai 2026; Sturznotizen der Tochter; kardiologischer Bericht vom 19. April 2026; Wohnungsbogen mit Türmaßen.

Vielen Dank für die kollegiale Mitbeurteilung.

Dr. med. Eva Stahlmann

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Hausarztpraxis Dr. med. Eva Stahlmann
Lange Straße 44 · 26122 Oldenburg
Telefon 0441 21893 · Telefax 0441 21894 · praxis@stahlmann.de
Dr. med. Eva Stahlmann · Fachärztin für Allgemeinmedizin

HILFSMITTELVERORDNUNG

Hausarztpraxis Dr. med. Eva Stahlmann · Lange Straße 44 · 26122 Oldenburg

Weser-Ems Gesundheitskasse
Leistungsbereich Hilfsmittel
26121 Oldenburg

Datum	16. Mai 2026
Aktenzeichen	WEK-418-77-920 / Hilfsmittel
Bearbeitung	Dr. med. Eva Stahlmann

Kompakter Elektrorollstuhl mit individueller Sitzanpassung

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Verordnung

Verordnet wird ein kompakter Elektrorollstuhl mit individueller Sitzanpassung, Kippschutz, Beleuchtung und Fahrtraining, geeignet für Innenräume, Hauseingang, Gehweg und tägliche Wege im Nahbereich. Die konkrete Modellauswahl soll nach Wohnungsprüfung und Erprobung erfolgen.

2. Funktionelle Begründung

Herr Körner kann kurze Schritte in der Wohnung nur unter erheblicher Sturzgefahr gehen. Unterarmgehstütze und Rollator gleichen Polyneuropathie, Gleichgewichtsstörung und rasche kardiale Erschöpfung nicht ausreichend aus. Ein manueller Rollstuhl kann wegen Schulterarthrose, eingeschränkter Handkraft und Belastungsdyspnoe nicht selbstständig angetrieben werden.

3. Untersuchung

Bei der Untersuchung am 16. Mai wurde die Gehstrecke mit Unterarmgehstütze nach 18 Metern abgebrochen. Der Puls stieg auf 118 pro Minute; es bestanden deutliche Dyspnoe und unsicherer Stand beim Wenden. Transfers vom Stuhl gelangen mit Armstütze. Aufmerksamkeit und Bedienverständnis waren unauffällig.

4. Versorgungsziel

Ziel ist die selbstständige Erschließung des Nahbereichs: Briefkasten, Hausarzt, Apotheke, Bäcker, Supermarkt, Friedhof und soziale Kontakte. Die Versorgung dient nicht einer bloßen Komfortsteigerung. Eine praktische Erprobung mit dokumentierter Fahrstrecke wird empfohlen.

Für medizinische Rückfragen stehe ich nach Entbindung von der Schweigepflicht zur Verfügung.

Dr. med. Eva Stahlmann

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Facharztbericht Mobilität und Sturzrisiko

Praxis Dr. Malte Radtke, Facharzt für Orthopädie und Neurologie

Nadorster Straße 91, 26123 Oldenburg

Bericht vom 17.05.2026

Untersuchungsanlass

Vorstellung auf Überweisung der Hausärztin zur Beurteilung der Mobilität und Hilfsmittelversorgung. Herr Körner berichtet über zunehmende Unsicherheit beim Gehen, Angst vor dem Verlassen der Wohnung und wiederholte Stürze.

Klinischer Befund

Bereich	Befund
Gangbild	kleinschrittig, breitbasig, unsicher, deutliche Starthemmung
Stand	Romberg unsicher, Tandemstand nicht möglich
Gehstrecke mit Unterarmgehstütze	14 Meter im Flur, danach Abbruch wegen Schwindel und Dyspnoe
Gehstrecke mit Rollator	32 Meter auf ebener Strecke, nur unter Aufsicht, keine Bordsteinbewältigung
Treppe	nicht sicher, nur mit beidseitigem Geländer und Begleitung
Kraft	Hüftbeugung links 3 von 5, Fußheber beidseits 3 von 5
Sensibilität	herabgesetzt an beiden Füßen, Vibrationsempfinden deutlich vermindert
Schulter rechts	schmerzhaft eingeschränkte Abduktion, manueller Rollstuhlantrieb nicht realistisch
Kognition	orientiert, versteht Verkehrsregeln, keine relevante Aufmerksamkeitsstörung

Bewertung

Eine sichere Gehfähigkeit im sozialmedizinisch brauchbaren Sinne besteht nicht mehr. Herr Körner kann in der Wohnung einzelne Transfers und wenige Schritte durchführen. Für Wege außerhalb der Wohnung ist er praktisch nicht mehr selbständig mobil.

Ein Gehstock oder eine Unterarmgehstütze ist nicht ausreichend. Die Sturzgefahr entsteht gerade durch Gleichgewichtsstörung, Sensibilitätsausfall und fehlende Ausdauer. Ein Rollator hilft auf ebenem Praxisflur, nicht aber im tatsächlichen Wohnumfeld mit Schwellen, Haustür, Bordstein, Pflasterung und Verkehrsraum.

Ein manueller Rollstuhl scheidet als selbständige Lösung aus. Wegen Schulterbefund, Herzinsuffizienz und geringer Ausdauer wäre Herr Körner auf eine Begleitperson angewiesen. Der Behinderungsausgleich würde dann nicht durch das Hilfsmittel selbst, sondern durch fremde Hilfe erreicht.

Empfehlung

Aus fachärztlicher Sicht ist ein kompakter Elektrorollstuhl medizinisch erforderlich. Vor Bewilligung sollte ein Fahrtraining und eine Anpassung durch das Sanitätshaus erfolgen. Die Fahreignung erscheint bei langsamer Einstellung und Einweisung gegeben.

Beweiswert

Der Bericht beruht auf persönlicher Untersuchung, Gehprobe, neurologischem Befund und Auswertung der hausärztlichen Unterlagen. Eine reine Aktenprüfung ohne Gehprobe kann die tatsächliche Mobilität nur eingeschränkt beurteilen.

Eigenschilderung Alltag und Wege

Heinz Körner

aufgenommen am 21.05.2026 durch Tochter Maren Körner, vom Versicherten gegengelesen

Mein Morgen

Ich komme vom Bett bis zum Bad, wenn ich mich an der Kommode, am Türrahmen und am Waschbecken festhalte. Ich brauche dafür ungefähr zehn Minuten. Wenn ich schnell muss, geht es nicht. Ich habe im Flur einen Stuhl stehen, damit ich mich nach dem Bad setzen kann.

Den Rollator nutze ich in der Wohnung nicht gern, weil er an der Badezimmerschwelle hängen bleibt. Die Küche ist schmal. Wenn ich den Rollator wende, stoße ich an den Schrank. Mit dem Stock fühle ich mich nicht sicher. Der Stock hilft nur, wenn die Beine mitmachen.

Wege außer Haus

Ziel	Entfernung	Aktueller Zustand
Briefkasten im Erdgeschoss	etwa 35 Meter mit Treppe und Haustür	nur mit Pause und Festhalten am Geländer
Hausarzt	etwa 260 Meter	seit April nur noch mit Taxi oder Tochter
Apotheke	etwa 310 Meter	Sturz am 03.05.2026 vor der Rampe
Bäcker	etwa 420 Meter	seit Februar nicht mehr allein
Supermarkt	etwa 650 Meter	nur mit Tochter, ich sitze im Auto
Friedhof Gertrudenfriedhof	etwa 1.2 Kilometer	seit Weihnachten nicht mehr besucht

Warum ich den Elektrorollstuhl brauche

Ich möchte nicht sportlich fahren. Ich möchte zum Briefkasten, zum Arzt, zur Apotheke und manchmal zum Grab meiner Frau. Meine Tochter arbeitet im Klinikum. Sie kann nicht immer kommen. Ich rufe oft nicht an, weil ich ihr nicht zur Last fallen will.

Wenn ich mit dem Rollator draußen bin, schaue ich nur auf den Boden. Bei Bordsteinen weiß ich nicht, wie ich hinüberkommen soll. Ich bin einmal auf die rechte Seite gefallen und einmal nach hinten. Danach lag ich im Hausflur, bis der Nachbar kam.

Einen normalen Rollstuhl kann ich nicht selbst schieben. Ich habe es bei RehaTechnik Albrecht probiert. Nach wenigen Metern taten Schulter und Brust weh. Ich kam nicht geradeaus. Ich will nicht wieder abhängig davon sein, dass jemand mich schiebt.

Wohnung

Ich wohne seit 1979 in der Wohnung. Meine Frau ist dort gestorben. Ein Umzug ist für mich schwer vorstellbar. Der Vermieter hat gesagt, dass ein Treppenlift wegen des engen Treppenhauses und des Fluchtwegs nicht genehmigt wird. Ein Aufzug ist nicht vorhanden. Es gibt aber eine breite Abstellfläche im Erdgeschoss hinter der Haustür, dort könnte der Elektrorollstuhl stehen und geladen werden. Für die Wohnung selbst brauche ich ihn in Küche und Flur nur langsam, aber ich brauche ihn vor allem, um aus dem Haus und wieder zurückzukommen.

RehaTechnik Albrecht GmbH

Donnerschweer Straße 188, 26123 Oldenburg · Telefon 0441 73 60 18

Ortstermin: 18. Mai 2026 · Versicherter: Heinz Körner · Beraterin: Anja Voss

Wohnungsumfeld und Barrierefreiheitsprüfung

Betreff: Prüfung der Einsatzfähigkeit eines kompakten Elektrorollstuhls im Wohnumfeld Theaterwall 62, 26122 Oldenburg.

Der Ortstermin fand im Beisein von Herrn Körner und seiner Tochter Maren Körner statt. Die Messwerte beruhen auf unmittelbarer Aufnahme vor Ort; Fotos liegen der Handakte bei.

Gebäudezugang

Der Hauseingang hat zwei Stufen mit 14 und 16 Zentimetern Höhe. Im Hausflur beträgt die lichte Breite 108 Zentimeter. Der Plattformlift beginnt erst im Hochparterre, überbrückt dort den Niveauversatz zum Hofsteg und erschließt das erste Obergeschoss nicht.

Wohnungsbereich

Flur und Wohnzimmer wurden vermessen. Die Küche hat an der engsten Stelle 60 Zentimeter Durchgangsbreite. In der Wohnung wurde kein kompletter Fahrversuch unternommen. Die Badezimmertür ist mit 68 Zentimetern zu schmal; dort bleibt Hilfestellung erforderlich.

Praktische Konsequenz

Der Elektrorollstuhl ersetzt nicht jede bauliche Barriere. Er kann voraussichtlich Wege ab Erdgeschoss ermöglichen. Ob Zugang zum Erdgeschoss, Schwelle, Ladeplatz und die Fahrt im Nahbereich in der Praxis zusammen funktionieren, ist noch zu erproben. Die Versorgung ist deshalb nicht mit einem bloßen Gehstock vergleichbar.

Kostenvoranschlag und technische Versorgung

RehaTechnik Albrecht GmbH

Donnerschweer Straße 188, 26123 Oldenburg

Kostenvoranschlag vom 20.05.2026

Versicherter

Heinz Körner, geboren 14.03.1948

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Vorgeschlagene Versorgung

Position	Beschreibung	Betrag
Elektrorollstuhl Permobil M1 Compact	Innen- und Nahbereichsversorgung, reduzierte Geschwindigkeit, kompakter Wendekreis	7.980,00 EUR
Sitzanpassung	druckentlastendes Sitzkissen, Beckengurt, seitliche Führung	1.240,00 EUR
Bedienmodul rechts	fein justierbarer Joystick, Handauflage	420,00 EUR
Beleuchtung und Reflektoren	Nahbereich und Straßenquerung	310,00 EUR
Bordsteinassistent klein	Kippstabilität bei niedrigen Kanten	390,00 EUR
Einweisung und Fahrtraining	zwei Termine vor Ort, Tochter anwesend	360,00 EUR
Wartungspauschale erstes Jahr	sicherheitsrelevante Kontrolle	290,00 EUR
Gesamt brutto	einschließlich Lieferung	10.990,00 EUR

Technische Begründung

Ein Standard-Faltrollstuhl ist im Fall Körner nicht geeignet, weil der Versicherte ihn nicht selbst antreiben kann. Ein Elektrorollstuhl mit großer Außenbereichsausführung ist technisch nicht erforderlich und im Gebäude schwer handhabbar. Das vorgeschlagene Modell ist bewusst kompakt gewählt.

Die Versorgung ist darauf ausgelegt, im Erdgeschoss abgestellt und geladen zu werden. Für die zwei Eingangsstufen ist eine mobile Kurzrampe gesondert möglich. Das Hilfsmittel ersetzt keinen Treppenlift und keine Wohnraumanpassung.

Fahrprobe

Am 18.05.2026 wurde im Innenhof eine langsame Fahrprobe durchgeführt. Herr Körner konnte nach 25 Minuten Einweisung:

1. geradeaus fahren,
2. in Schrittgeschwindigkeit wenden,
3. anhalten,
4. eine Türschwelle mit Begleitung überwinden,
5. den Joystick rechts sicher bedienen.

Kritisch bleibt das Rückwärtsfahren. Es wird empfohlen, den Rollstuhl zunächst auf niedrige Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen und nach drei Wochen eine Nachschulung durchzuführen.

Für die Weser-Ems Gesundheitskasse
Heinz Körner · WEK-418-77-920 · Vorgang HM-2026-7714-E
5. Juni 2026 · schriftliche Stellungnahme nach Aktenlage

Sozialmedizinische Stellungnahme zur Hilfsmittelversorgung

1 Prüfauftrag

Die Krankenkasse bittet um die sozialmedizinische Beurteilung, ob die beantragte Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl anhand der übermittelten Befunde erforderlich erscheint. Gegenstand der Beratung sind die medizinischen Funktionen und die Eignung der benannten Hilfsmittel. Über den Antrag entscheidet die Krankenkasse. Eine Untersuchung oder persönliche Erprobung durch den Medizinischen Dienst war im Auftrag nicht vorgesehen und hat nicht stattgefunden.

2 Übermittelte Unterlagen

Unterlage	Datum	Erkenntnis für die Beratung
Antrag und hausärztliche Verordnung	22. und 16. Mai	Elektrische Versorgung für Innenräume und wohnungsnahe Wege, keine bindende Modellauswahl
Orthopädisch neurologischer Befund	17. Mai	Gehprobe mit Stütze und Rollator, motorische und sensible Einschränkungen
Wohnumfeldnotiz und Angebot	18. und 20. Mai	Maße und Kosten, Hofprobe nach Einweisung, noch ungeklärter Gebäudezugang
Eigene Schilderung des Versicherten	21. Mai	Berichtete Stürze, Entfernungen, Unterstützung durch Tochter und Nachbarn

Ausführliche Dokumentationen der Ergotherapie und der Physiotherapie liegen dem Medizinischen Dienst bei Abgabe dieser Stellungnahme nicht vor. Der Bericht des Sanitätshauses erwähnt eine Erprobung im Hof. Die Angaben enthalten keinen Test der im Kassenvertrag verfügbaren Ausführung. Auch ist nicht festgehalten, wie häufig für außerhäusliche Wege tatsächlich eine Begleitung zur Verfügung steht. Angaben zu Herzinsuffizienz und Schulterbeschwerden beruhen auf den Berichten der behandelnden Ärzte. Ein aktueller Belastungsbericht der Kardiologie ist nicht beigefügt.

3 Funktioneller Befund nach Unterlagen

3.1 Gehen und Umsetzen

Die Akte beschreibt eine Kombination aus lumbaler Spinalkanalstenose, sensomotorischer Polyneuropathie, Belastungsdyspnoe und Bewegungseinschränkung nach Hüfttotalendoprothese links. Entscheidend für die Gehhilfe ist, dass das Gangbild breitbasig und kleinschrittig ist und der Versicherte sich beim Richtungswechsel nicht durchgehend stabilisiert. Die hausärztliche Gehprobe mit Unterarmgehstütze endete nach 18 Metern. Die fachärztliche Untersuchung ergab mit der Stütze 14 Meter und mit dem Rollator auf ebenem Flur 32 Meter unter Aufsicht. Zwischen diesen Beobachtungen besteht kein wesentlicher Widerspruch. Die Ergebnisse betreffen unterschiedliche Geräte und

Bedingungen. Aus der beobachteten Strecke lässt sich keine nachgewiesene sichere Gehstrecke im öffentlichen Raum ableiten.

Im häuslichen Umfeld gibt der Versicherte an, den Weg vom Bett ins Bad mit Halt an Möbeln noch zu bewältigen. Die Transfers wurden in der hausärztlichen Stellungnahme als unter Verwendung der Armstützen möglich beschrieben. Für die Beratung folgt daraus, dass Restfunktionen vorhanden sind. Ihre Nachhaltigkeit ist aus den Unterlagen nur begrenzt abschätzbar. Zum Anheben des Rollators an Schwellen, zum Öffnen der Haustür während des Gehens und zu einem vollständigen Hin- und Rückweg unter Belastung liegt keine einheitliche Messreihe vor.

3.2 Armfunktion und Rollstuhlantrieb

Der Facharzt nennt Schmerzen und Einschränkungen der rechten Schulter. Ein ärztlich beobachteter Test über eine längere Strecke mit angepasstem Aktivrollstuhl ist nicht beigefügt. Aus der Hofprobe des Leistungserbringers ergibt sich eine Lenkabweichung mit dem getesteten Faltstuhl. Sitzmaße und Greifreifenlage dieses Stuhls sind nicht vollständig dokumentiert. Offen bleibt, ob die beobachtete fehlende eigenständige Nutzbarkeit aus der Armfunktion, aus der konkreten Gerätepassung oder aus beiden Faktoren folgt. Bei Transfers ist die Nutzung der oberen Extremität möglich. Eine Transferbewegung beansprucht Schulter und Kreislauf anders als ein länger wiederholter Antrieb. Aus dem Gelingen des Transfers wird deshalb keine ausdauernde Antriebsfähigkeit abgeleitet.

3.3 Umgang mit der elektrischen Steuerung

Der Versicherte hat die Joysticksteuerung nach kurzer Einweisung im Hof benutzt. Bei niedriger Geschwindigkeit gelangen kontrolliertes Anhalten und langsames Wenden. Für selbstständiges Fahren auf öffentlichem Gehweg fehlen Angaben zu gleichzeitiger Aufmerksamkeit für andere Verkehrsteilnehmer, Rückwärtsfahren an Engstellen und Befahren von Schwellen. Im Antrag wird die Lage des Geräts im Erdgeschoss erwogen. Der Rollstuhl überbrückt den Zugang von der Wohnung zum Erdgeschoss selbst nicht. Ein Nachweis für eine dauerhaft nutzbare Lade- und Abstellmöglichkeit ist nicht beigefügt.

3.4 Einordnung der Transportwege

Eine Erprobung bis zur Wohnungstür unterscheidet sich vom Erreichen eines gewöhnlichen Ziels im Freien. In der Akte werden der Briefkasten im Erdgeschoss, die Hausarztpraxis in ungefähr 260 Metern Entfernung und die Apotheke in ungefähr 310 Metern Entfernung genannt. Die Wegebeobachtung im Praxisflur bildet keinen dieser Abläufe in voller Länge ab. Für eine wiederholte Nutzung sind Wartezeit, Rückweg und verfügbare Sitzmöglichkeiten mit zu berücksichtigen. In den bisher übermittelten Unterlagen ist auch nicht angegeben, ob die angegebenen Entfernungen von der Wohnungstür oder vom Straßenausgang aus geschätzt wurden.

Für die Beurteilung einer vorübergehenden Begleitversorgung wäre getrennt festzuhalten, ob eine Begleitperson nur bei der Treppe, beim Transport im Fahrzeug oder während der gesamten Strecke gebraucht wird. Ein positives Ergebnis beim Transfer in ein Auto sagt nichts über die Möglichkeit eigenständiger Erledigungen im Nahbereich aus. Angaben zur Gelegenheit, sich am Ziel hinzusetzen, zur Wiederholung der Strecke nach einer Pause und zu etwaiger Hilfe beim Rückweg fehlen. Dies begrenzt die Aussagekraft sowohl der klinischen Gehstrecken als auch der bisherigen kurzen Fahrprobe. Im Verlauf sollten für dieselbe Tätigkeit die regelmäßigen Bedingungen erfasst werden. Einzelne besonders gute oder schlechte Tage sind dabei als solche zu vermerken.

4 Vergleich der Versorgungsmöglichkeiten

Für kurze Teilstrecken im ebenen Innenraum erscheint die vorhandene Versorgung mit Rollator nach den beigefügten Unterlagen nutzbar. Außerhalb der ebenen Fläche ist die Reichweite geringer und

hängt von Begleitung sowie Untergrund ab. Die zusätzliche Unterarmgehstütze kann nach Aktenlage bei einzelnen Transfers und auf engem Raum hilfreich sein. Eine alleinige Versorgung mit Stütze für den Wohnungsnahbereich wird sozialmedizinisch nicht befürwortet. Ein Therapieprogramm zur Sturzvermeidung ist als ergänzende Maßnahme sinnvoll, ersetzt jedoch die Erhebung der tatsächlichen Ausdauer nicht.

Ein Standard-Faltrollstuhl kann bei Begleitung sichere Sitzmobilität bieten und weitere Stürze beim Gehen vermeiden. Ob er eigenständig betrieben werden kann, wurde nicht hinreichend geprüft. Für längere Wege sieht die gegenwärtige Beratung begleitete Fortbewegung als mögliche Versorgung an. Die Annahme beruht darauf, dass die Tochter in der Eigenschilderung mehrfach als Begleitung genannt wird. Ein Einsatzplan oder ein vertraglich gesicherter Begleitdienst sind nicht dokumentiert. Die Auswirkung dieser Annahme auf die selbstständige Erschließung gewöhnlicher Alltagswege sollte bei der Leistungsentscheidung bedacht werden.

Die beantragte elektrische Versorgung mit rechtsseitigem Joystick erspart den wiederholten Einsatz beider Arme. Das Angebot enthält unter anderem individuell angepasstes Sitzen, Beleuchtung, Kippschutz und Einweisung. Bei einem Preis von 10.990 Euro sind die erforderlichen Bestandteile mit der tatsächlich verfügbaren Vergleichsversorgung abzugleichen. Der genannte Vertragspreis von ungefähr 740 Euro für einen Faltrollstuhl beschreibt lediglich die Kosten. Er sagt nichts über die Antriebsfähigkeit des Versicherten aus. Auch aus der bloßen Verfügbarkeit eines Rollators folgt keine Gleichwertigkeit mit einer motorisierten Versorgung für öffentliche Wege.

5 Sozialmedizinisches Ergebnis

Die Unterlagen belegen eine erhebliche Mobilitätseinschränkung und begründen einen Bedarf an sicherer Hilfsmittelnutzung. Die Erforderlichkeit der beantragten elektrischen Versorgung ist aus Sicht der Begutachtung noch nicht abschließend belegt. Empfohlen werden die vorläufige Weiternutzung geeigneter vorhandener Hilfsmittel auf den sicher bewältigbaren Teilstrecken und eine konkrete Erprobung eines angepassten Falt- oder Aktivrollstuhls. Vor einer positiven Aussage zur elektrischen Variante sind insbesondere der Einsatz ab Erdgeschoss, Abstellen und Laden sowie die selbstständige Nutzung im Nahbereich zu überprüfen.

Die Empfehlung, eine elektrische Vollversorgung derzeit nicht zu befürworten, setzt voraus, dass vorläufig begleitete Wege tatsächlich verfügbar sind und dass die technische Alternative erprobt werden kann. Sollten diese Voraussetzungen entfallen oder sollte sich die Armfunktion bei angepasstem Testgerät als nicht ausreichend erweisen, ist die Bewertung erneut vorzunehmen. Für die weitere Beurteilung sind die benutzte Wegstrecke, der Zeitbedarf, Hilfestellungen, Abbruchkriterien und die Beschwerden nach Wiederholung getrennt festzuhalten.

Dr. med. Kirsten Vollmer · Sozialmedizin

Ablehnungsbescheid der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungszentrum Hilfsmittel

Stau 35, 26122 Oldenburg

Oldenburg, 10.06.2026

Versicherter: Heinz Körner

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E

Bescheid

Sehr geehrter Herr Körner,

Ihren Antrag auf Versorgung mit einem Elektrorollstuhl vom 22.05.2026 lehnen wir ab.

Begründung

Nach Paragraf 33 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, wenn diese im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Die Leistung muss außerdem ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Der Medizinische Dienst hat die Unterlagen geprüft. Danach ist Ihre Gehfähigkeit eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Sie können kurze Strecken in der Wohnung und auf ebener Strecke mit Rollator zurücklegen. Eine Versorgung mit Unterarmgehstütze, Rollator und bei längeren Wegen mit Standard-Faltrollstuhl ist ausreichend.

Der beantragte Elektrorollstuhl kostet nach Kostenvoranschlag 10.990,00 EUR. Diese Versorgung ist im Verhältnis zu den vorhandenen einfacheren Hilfsmitteln nicht wirtschaftlich. Bauliche Erschwernisse Ihrer Wohnung und Ihres Hauseingangs können nicht durch eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeglichen werden. Für Wohnumfeldmaßnahmen wenden Sie sich bitte an Ihre Pflegekasse oder Ihren Vermieter.

Entscheidung

Wir übernehmen die Kosten für den beantragten Elektrorollstuhl nicht.

Wir bieten Ihnen an, über unser Vertragssanitätshaus einen Standard-Faltrollstuhl prüfen zu lassen. Bei Bedarf kann zusätzlich eine physiotherapeutische Gangschulung mit Ihrem behandelnden Arzt besprochen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Weser-Ems Gesundheitskasse einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungszentrum Hilfsmittel

Für Herrn Heinz Körner
Untersuchung am 17. Juni 2026 in Oldenburg
Bericht vom 18. Juni 2026

Funktioneller Erprobungsbericht zur Mobilität

1 Auftrag und Vorgehen

Herr Körner hat mich nach Erhalt des Bescheids gebeten, seine vorhandenen und die angebotenen Hilfsmittel unter alltagsnahen Bedingungen zu vergleichen. Gegenstand war die beobachtbare Handhabung im Gebäude und im Hof. Ich gebe keine ärztliche Diagnose, keine Aussage zur Bewilligung von Leistungen und keine Bestätigung für eine unbeaufsichtigte Fahrt im Straßenverkehr ab. Medizinische Befunde werden als solche bezeichnet. Eigene Beobachtungen und Angaben des Versicherten werden getrennt aufgeführt.

Anwesend waren der Versicherte, seine Tochter Maren und zeitweise der Hausmeister Ulf Bödeker. Am Vormittag war das Pflaster trocken. Die Versuche dauerten einschließlich Pausen und Aufmaß von 9.20 Uhr bis 11.35 Uhr. Kein Gerät wurde ohne Sicherungsmöglichkeit benutzt. Das Testfahrzeug wurde durch den Leistungserbringer für die Dauer des Termins bereitgestellt. Die Geschwindigkeit war für alle elektrischen Versuche auf eine niedrige Stufe eingestellt.

2 Beobachtete Ausgangslage

In der Wohnung stand Herr Körner vom Stuhl auf, indem er sich mit beiden Armen abstützte und zunächst an der Kommode festhielt. Beim Umsetzen auf den Versuchsstuhl benötigte er keine Hebehilfe. Die Tochter sicherte den Stuhl gegen Wegrollen und erinnerte ihn an die Fußstütze. Die Bremsen konnten mit der rechten Hand betätigt werden, wenn der Griff nach vorne versetzt und gut erreichbar war. Das Zurechtrücken des linken Fußes dauerte in zwei von drei Versuchen sichtbar länger.

Die Wohnung liegt im ersten Obergeschoss. Am Begehungstag gelangte Herr Körner mit Tochter und Handlauf in das Erdgeschoss. Ich habe den unteren Abschnitt bis zum Absatz beobachtet. Der Versicherte setzte die Füße einzeln nach und ruhte am Absatz. Eine wiederholte Bewältigung der ganzen Treppe war nicht Gegenstand der Erprobung. Der Rollstuhl soll nach Aussage des Versicherten im Erdgeschoss bleiben. Die Bedingungen hierfür hängen von der Hausverwaltung und der Elektroprüfung ab. Die Nutzung im Erdgeschoss kann daher nur als bedingter Teilgewinn beurteilt werden.

3 Vergleich in einzelnen Tätigkeiten

3.1 Unterarmgehstütze

Die Stütze wurde auf der rechten Seite geführt. Herr Körner ging etwa neun Meter auf der ebenen Strecke im Flur. Danach stand er mit beiden Füßen breit auseinander und versuchte, für die Wendung die Stütze zu versetzen. Er verlagerte den Oberkörper nach hinten. Ich sicherte am linken Oberarm und beendete den Versuch, bevor der Versicherte zu Boden hätte gehen können. Einen Hin- und Rückweg ohne Unterstützung konnte ich nicht beobachten. Nach der Pause gab er Schwindel an. Die Beobachtung sagt nichts darüber aus, ob die Stütze bei wenigen Schritten zwischen zwei festen Haltepunkten in der Wohnung brauchbar bleibt.

3.2 Rollator

Der mitgebrachte Rollator war gebremst und auf die gewohnte Griffhöhe eingestellt. Herr Körner ging im Flur 19 Meter. In der Wendung brauchte er eine mündliche Anleitung und blieb einmal stehen, weil

der linke Fuß die hintere Traverse berührte. Draußen näherte er sich der abgesenkten Bordsteinkante. Bei der Vorbereitung zum Anheben der Vorderräder verlagerte er zu viel Gewicht auf die Arme. Der Versuch wurde vor der Überfahrt beendet. Das Gerät wirkte auf der ebenen Teilstrecke stabilisierend. An der Kante fehlte dem Versicherten eine gleichzeitig verfügbare Stützfläche, während er die Räder bewegte. Die Grundstrecke zum Arzt wurde mit diesem Gerät an dem Tag nicht versucht.

3.3 Manueller Faltrollstuhl

Getestet wurde ein Standard-Faltrollstuhl des Sanitätshauses. Der rechte Greifreifen war für Herrn Körner erreichbar, links fehlte bei mehreren Antriebsbewegungen der gleichzeitige Kontakt. Auf dem Hofkurs driftete der Stuhl nach links. Der Versicherte korrigierte mit der rechten Hand, hielt an und fasste erneut. Nach der kurzen Strecke nannte er Schulterschmerzen rechts. Die Tochter schob den Stuhl zurück. Der Versuch belegt die Schwierigkeiten mit diesem Gerät. Ein fachgerecht eingestellter manueller Aktivrollstuhl mit geringerem Rollwiderstand war bei diesem Termin nicht verfügbar. Ein schiebender Angehöriger hätte das Gerät als Transportmittel nutzen können. Eine Aussage zur tatsächlichen Verfügbarkeit einer solchen Person kann ich aus der Beobachtung nicht treffen.

3.4 Elektrorollstuhl

Das elektrische Testgerät war mit einem rechtsseitigen Joystick und Armauflage ausgerüstet. Herr Körner setzte sich mit Unterstützung beim Fußbügel in den Stuhl. Nach einem Durchgang zum Einstellen der Handauflage lenkte er auf dem Hof geradeaus, folgte einer Kurve und stoppte jeweils auf Ansprache. Die Bedienhand blieb auf der Auflage. Ein unerwartetes Bremskommando wurde in Schrittgeschwindigkeit aufgenommen und umgesetzt. Bei der Einfahrt zur hinteren Tür setzte er die erste Kurve zu spät an. Nach dem Hinweis fuhr er auf derselben Strecke mit besserem Abstand zurück. Das Öffnen der geschlossenen Tür aus dem Sitz wurde nicht erfolgreich gezeigt. Der Hausmeister hielt den Flügel beim Versuch fest.

4 Beobachtung und Versorgungsvoraussetzungen

Mit dem Elektroantrieb entfällt das sich wiederholende beidseitige Greifen am Reifen. Das ist bei der beobachteten Armfunktion ein erheblicher Unterschied. Die günstige Beobachtung bezieht sich auf eine ebene, bekannte und beaufsichtigte Fläche. Sie ist keine Verkehrserprobung. Vor der Abgabe empfehle ich ein Training mit klaren Abbruchkriterien für Verwirrung, falsch dosiertes Bremsen oder wiederholten Kontakt mit einer Engstelle. Die Einweisung sollte ein- und ausfahren, umsetzen, Laden, die hintere Tür sowie eine kurze realistische Versorgungsstrecke umfassen. Erst danach lässt sich die Eignung für den Gebrauch ohne Sicherung durch eine zweite Person beurteilen.

Der in Aussicht gestellte Trockenraum bietet eine mögliche Alternative zum Rettungsweg. Ob der Schlüssel in der sitzenden Position bedient werden kann, wurde noch nicht geprüft. Eine elektrische Freigabe liegt mir nicht vor. Die Frage, wer den Versicherten vom ersten Obergeschoss hinunter und zurück begleitet, ist davon unabhängig. Die Tochter hat von wechselnden Dienstzeiten berichtet. Die konkrete Häufigkeit ist mir nicht bekannt.

4.1 Kurzstrecke, Rückweg und Belastungswechsel

Die mit dem Elektrorollstuhl ausprobierte Fahrt schloss die Rückkehr zum Ausgangspunkt im Hof ein. Sie enthielt keine längere Unterbrechung wie bei einem Praxisbesuch. Beim Rollatorversuch war eine kurze Sitzpause nötig, bevor der Versicherte im Flur weiterging. Der Faltrollstuhl wurde nach dem Versuch von der Tochter zurückgeschoben. Damit wäre es unzutreffend, die jeweils genannten einfachen Entfernungen zu verdoppeln und als selbstständig zurückgelegte Gesamtstrecke zu werten. Bei der Fortsetzung der Erprobung sollte derselbe Hinweg nach einer realistischen Wartezeit wiederholt

werden. Vor Beginn des Rückwegs sind Erschöpfung, Aufstehen oder Umsetzen und die Fähigkeit zur erneuten Steuerung festzuhalten.

4.2 Folgen des Transports mit Kraftfahrzeug

Der Hausmeister beobachtete, wie Herr Körner am Ende des Termins vom Versuchsstuhl auf den festen Stuhl im Trockenraum wechselte. Den Transfer in ein Kraftfahrzeug habe ich nicht selbst gesehen. Die Tochter beschrieb, dass er zu Arztterminen über einen möglichst kurzen Weg zum Fahrzeug geführt wird und sich bei geöffnetem Beifahrersitz umsetzen kann. Für die Frage der eigenen Bewegung im Nahbereich hat der Autotransfer eine begrenzte Aussagekraft. Mit einer Fahrt können einzelne geplante Termine abgesichert werden. Ob der Versicherte bei einem ungeplanten Besuch die Wohnung, die Straße, das Geschäft und den Rückweg selbst bewältigen kann, wurde damit nicht geprüft. Eine Fahrzeugverladung des schweren Elektrorollstuhls war nicht Gegenstand des Termins.

4.3 Messgrenzen und Wiederholung

Die gemessenen Strecken sind keine Belastungstests mit standardisierten Laborbedingungen. Das Ergebnis hängt von trockenem Boden, der verfügbaren Sicherung und dem an diesem Tag erreichten Ausgangszustand ab. Es sollte bei der nächsten Prüfung neben dem jeweiligen Gerät auch festgehalten werden, ob der Versicherte vor dem Versuch bereits Treppen gegangen ist. Gerade dieser Wechsel zwischen Treppe, Umsetzen und Fahren gehört zum Alltag. Eine Wiederholung bei trockener Oberfläche und später bei den sonst regelmäßig auftretenden Bedingungen wäre aussagekräftiger als die Verallgemeinerung einer einzigen Hofrunde.

5 Weitere Vergleichsprüfung

Der beobachtete Unterschied spricht dafür, ein kompaktes elektrisch gesteuertes Hilfsmittel mit funktionsangepasster Sitzposition weiter zu erproben. Für den Vergleich sind ein leichter manueller Aktivrollstuhl und ein elektrisch unterstütztes System mit einhändig unabhängig bedienbarer Steuerung einzubeziehen, soweit solche Geräte verfügbar sind. Dabei ist dieselbe Strecke mit denselben Aufgaben zu verwenden. Ein Prüfblatt sollte Dauer, Pausen, Beschwerdeanstieg, Fehler bei Antrieb und Bremse, Unterstützung und den Rückweg ausweisen. Eine Begleitperson kann bei der Erprobung aus Sicherheitsgründen nötig sein. Entscheidend für den Befund ist, ob sie tatsächlich in die Fahrt eingreifen musste.

Sven Falke · Rehabilitationspädagoge

Heinz Körner · Theaterwall 62 · 26122 Oldenburg

Weser-Ems Gesundheitskasse · Leistungszentrum Hilfsmittel
Stau 35 · 26122 Oldenburg
Oldenburg, 17. Juni 2026 · WEK-418-77-920 · HM-2026-7714-E

Widerspruch gegen den Hilfsmittelbescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich widerspreche Ihrem Bescheid vom 10. Juni 2026. Ich habe den Brief am Freitag, dem 12. Juni, aus dem Briefkasten bekommen. Bitte bestätigen Sie mir, wann dieses Schreiben bei Ihnen eingegangen ist. Ich möchte weiterhin den Rollstuhl bekommen, mit dem ich nach Erprobung selbst fahren kann. Gegen einen anderen, ebenso brauchbaren Rollstuhl aus Ihrem Bestand habe ich nichts.

1 Was ich mit Rollator und Stütze noch machen kann

In der Wohnung stelle ich den Rollator quer an die Wand, wenn ich an den Kleiderschrank muss. Schon dabei kann ich nicht zugleich beide Bremsen halten. Auf einem geraden Flur schaffe ich ein Stück, wenn jemand neben mir geht. Das war bei der Untersuchung so. Ich verstehe aber nicht, wie ich damit allein zur Apotheke kommen soll. Die Tür kann ich beim Gehen nicht sicher aufhalten und draußen muss ich auf den Boden schauen, damit ich die Füße richtig setze. Wenn ein Fahrrad oder ein anderer Mensch kommt, muss ich stehen bleiben. Wenn ich stehen bleibe, brauche ich irgendwann einen Stuhl.

Beim Sturz im Hausflur Ende April hat mich ein Nachbar aufgehoben. Vor der Apotheke Anfang Mai rief jemand meine Tochter an, weil ich die Unterarmstütze nach dem Sturz nicht wieder fest greifen konnte. Seitdem bitte ich meine Tochter, Medikamente abzuholen. Einmal brachte die Apotheke sie nach Hause. Das war freundlich und hilft, wenn es um die Packung geht. Einen Arzttermin oder eine Nachfrage mit meinen Tabletten kann ich so nicht selbst erledigen.

2 Weshalb ich mit dem leichten Stuhl aus Ihrem Angebot einen Versuch brauche

Ich habe im Hof einen gewöhnlichen Rollstuhl versucht. Links kam die Hand nicht gut an den Reifen, rechts musste ich dauernd dagegen arbeiten. Nach wenigen Metern zog es in der rechten Schulter. Meine Tochter schob mich zurück. Sie ist bereit, mich manchmal zu fahren oder zu schieben, aber sie arbeitet in wechselnden Schichten und kann ihre Termine nicht nach meinen Tabletten und dem Arzt ausrichten. Bitte teilen Sie mir die genaue Bezeichnung und die Maße des angebotenen Stuhls mit. Vielleicht lässt sich ein anderes Modell besser bedienen. Den Versuch würde ich gern im Hof machen, weil dort die Tür und der Boden so sind wie auf meinem täglichen Weg.

3 Was ich mit dem elektrisch gesteuerten Stuhl ausprobieren konnte

Im Hof wurde mir ungefähr eine halbe Stunde gezeigt, wie der rechte Hebel funktioniert. Beim Anhalten klappte es. Rückwärts war ich zu nahe an der Wand und musste neu ansetzen. Für mich gehört zur Versorgung, dass mir jemand das am Abstellplatz beibringt. Ich will mit einem Stuhl zur Apotheke kommen, mit dem ich langsam und sicher fahre. Ich habe keinen Wunsch nach einer großen Reichweite oder nach schneller Fahrt. Sollte ein angebotener Stuhl mit anderer Ausstattung das ermöglichen, möchte ich ihn kennenlernen.

4 Die Treppe und der Hof

Ich wohne im ersten Stock. Den Stuhl stelle ich mir unten vor. Den oberen Teil der Strecke würde ich zunächst mit Hilfe machen, wie schon bei Arztbesuchen. Im Flur darf das Gerät laut Hausverwaltung nicht stehen. Der Hausmeister hat uns den Raum am Hinterausgang gezeigt. Den Stromanschluss und die Schwelle prüfen sie noch. Der Stuhl soll erst geliefert werden, wenn ich hinein- und hinauskomme

und er dort geladen werden darf. Bitte helfen Sie dabei, die Frage mit dem Sanitätshaus zu prüfen, bevor Sie über das Gerät endgültig entscheiden.

4.1 Wie es bei einer Besorgung tatsächlich abläuft

Wenn meine Tochter mich zum Arzt fährt, klingelt sie zuerst bei mir. Ich lege den Schlüssel und die Tablettenschachtel vorher auf das Brett neben der Tür. Sie wartet, bis ich mich angezogen habe, und geht auf der Treppe vor mir. Unten kann ich mich im Auto setzen. Wenn der Termin länger dauert, muss sie jemanden auf ihrer Arbeit anrufen oder ich muss warten. Für den Weg zur Apotheke braucht man eigentlich kein Auto. Ich brauche aber im Augenblick jemanden, der mich hinbringt und am Ende wieder abholt. Bei kleinen Fragen zu einem Rezept wäre es mir lieber, wenn ich hingehen und selbst nachfragen könnte.

Beim ersten Versuch mit dem Rollator war der Boden im Hof trocken. Bei Regen steht am Rohr eine Pfütze, an der ich mich seitlich vorbeidrücken müsste. Mit der Stütze komme ich dort kaum um die Ecke. Ich habe nicht ausprobiert, ob ich mit dem Rollstuhl bei Regen dort sicher vorbeikomme. Ich möchte das nicht ohne Anleitung versuchen. Meine Tochter sagt, dass wir beim ersten Termin nur im Hof gefahren sind. Einen Bericht, der behauptet, ich sei schon über die Straße gefahren, könnte ich deshalb nicht bestätigen.

Meine Tochter könnte manchmal noch am Anfang und Ende helfen. Ob es dafür zwei feste Tage geben kann, müssen wir mit ihrem Dienstplan besprechen. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit dem neuen Rollstuhl die Treppe hinunterfahren will. Ich meine die Wege, die unten anfangen. Wenn es dafür einen Vorschlag gibt, möchte ich ihn zusammen mit der Hausverwaltung und dem Sanitätshaus ausprobieren.

5 Welche Unterlagen ich nachreichen möchte

Den Befund von Dr. Radtke und die Unterlagen vom Sanitätshaus haben Sie bereits. Heute fand im Hof noch ein Termin mit Herrn Falke statt. Seinen Bericht habe ich noch nicht. Ich reiche ihn nach, sobald er mir vorliegt. Falls Ihrem Medizinischen Dienst die Unterlagen zu wenig sagen, möchte ich die Wege und die Handhabung bei einem Termin selbst zeigen. Bitte senden Sie mir auch die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes in Kopie. Ich will verstehen, unter welchen Bedingungen dort ein Rollator und ein Faltrollstuhl als ausreichend beschrieben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Körner

Eingang bei der Widerspruchsstelle laut Eingangsstempel am 20. Juni 2026.

Kurzniederschrift zum Widerspruchsbescheid

Weser-Ems Gesundheitskasse

Widerspruchsstelle

Stau 35, 26122 Oldenburg

Oldenburg, 24.06.2026

Versicherter: Heinz Körner

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E-W

Entscheidung

Der Widerspruch gegen den Bescheid vom 10.06.2026 wird zurückgewiesen.

Gründe

Der Ausgangsbescheid ist rechtmäßig. Ein Anspruch auf Versorgung mit dem beantragten Elektrorollstuhl besteht nicht.

Die Widerspruchsstelle hat die ärztlichen Unterlagen, die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes und das von Ihnen vorgelegte private Reha-Gutachten geprüft. Danach bestehen Einschränkungen der Mobilität. Eine vollständige Gehunfähigkeit ist jedoch nicht belegt. Der Versicherte kann nach den Unterlagen kurze Strecken gehen. Für längere Wege kommt ein Standard-Faltrollstuhl in Betracht.

Das private Reha-Gutachten führt zu keiner anderen Bewertung. Es wurde im Auftrag des Versicherten eingeholt und ersetzt keine sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst. Zudem bestätigt auch dieses Gutachten, dass Transfers und einzelne Gehstrecken möglich sind.

Die beantragte Versorgung überschreitet das Maß des Notwendigen. Der Elektrorollstuhl ist mit Kosten von 10.990,00 EUR erheblich teurer als die einfache Versorgung. Nach Paragraf 12 SGB V müssen Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.

Soweit Sie auf bauliche Hindernisse im Treppenhaus, den Hauseingang und die fehlende Barrierefreiheit verweisen, ist hierfür nicht die gesetzliche Krankenversicherung zuständig. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds können gegebenenfalls bei der Pflegekasse beantragt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Sozialgericht Oldenburg erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder nach Maßgabe der zugelassenen elektronischen Übermittlungswege erhoben werden.

Der Widerspruchsbescheid wurde am 26.06.2026 zugestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Weser-Ems Gesundheitskasse

Widerspruchsstelle

Entwurf Klageschrift

Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Fachanwälte für Sozialrecht

Staulinie 8, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 92 37 60-0

Rechtsanwalt Joost Ahlers

Unser Zeichen: 26-06-KR-1187

Nicht eingereicht. Stand 29.06.2026. Versand per beA nach Mandantenfreigabe.

An das Sozialgericht Oldenburg
Schlosswall 16
26122 Oldenburg

Klage

des Herrn Heinz Körner, Theaterwall 62, 26122 Oldenburg,

Kläger,

gegen

die Weser-Ems Gesundheitskasse, Stau 35, 26122 Oldenburg,

Beklagte.

Anträge

1. Der Bescheid der Beklagten vom 10.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24.06.2026 wird aufgehoben.
2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger mit einem geeigneten kompakten Elektrorollstuhl für Innenräume, Hausausgang und Nahbereich zu versorgen, hilfsweise über den Antrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.
3. Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers.

Sachverhalt

Der 78-jährige Kläger ist gesetzlich krankenversichert. Er leidet unter lumbaler Spinalkanalstenose, diabetischer Polyneuropathie, Zustand nach Hüft-TEP links, Herzinsuffizienz und wiederholten Stürzen. Er lebt allein in einem Altbau in Oldenburg. Sein täglicher Nahbereich umfasst Briefkasten, Hausarzt, Apotheke, Bäcker, Supermarkt und den Besuch des Grabes seiner Ehefrau.

Mit Verordnung vom 16.05.2026 beantragte der Kläger die Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl. Der Kostenvoranschlag der RehaTechnik Albrecht GmbH vom 20.05.2026 beträgt 10.990,00 EUR. Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 10.06.2026 ab und stützte sich auf eine reine Aktenstellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 05.06.2026. Den Widerspruch des Klägers vom 20.06.2026 wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026 zurück.

Rechtliche Würdigung

Der Kläger hat Anspruch auf Hilfsmittelversorgung nach Paragraf 33 SGB V. Das beantragte Hilfsmittel dient dem Behinderungsausgleich. Entscheidend ist nicht, ob der Kläger noch einzelne Schritte in der Wohnung leisten kann. Entscheidend ist, ob die angebotene Versorgung den konkreten Mobilitätsbedarf im Basisausgleich praktisch deckt.

Gehstock, Unterarmgehstütze und Rollator sind nach den vorliegenden Befunden nicht ausreichend. Sie setzen eine sichere Restgehfähigkeit voraus, die beim Kläger gerade fehlt. Ein Standard-Faltrollstuhl ist ebenfalls ungeeignet, weil der Kläger ihn wegen Schulterbeschwerden, Herzinsuffizienz und geringer

Ausdauer nicht selbständig antreiben kann. Eine Versorgung, die nur mit schiebender Begleitperson funktioniert, stellt keine selbständige Mobilität her.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Paragraf 12 SGB V rechtfertigt die Ablehnung nicht. Wirtschaftlich ist nicht das billigste Hilfsmittel, sondern das ausreichende und zweckmäßige Hilfsmittel. Ein günstiger Rollstuhl, der den Versorgungszweck verfehlt, ist nicht wirtschaftlich.

Die Beklagte hat die konkrete Bedarfslage unzureichend ermittelt. Der Medizinische Dienst hat den Kläger nicht persönlich untersucht, keine Gehprobe durchgeführt, das Wohnumfeld nicht gesehen und den Test des manuellen Rollstuhls nicht nachvollzogen. Dem stehen der fachärztliche Bericht, die hausärztliche Verordnung und das private Reha-Gutachten mit persönlicher Untersuchung gegenüber.

Beweisangebote

4. Bericht Dr. Radtke vom 17.05.2026.
5. Verordnung Dr. Stahlmann vom 16.05.2026.
6. Gutachten Reha-Kompetenz Nordwest vom 18.06.2026.
7. Zeugin Maren Körner zu Stürzen, Alltagswegen und fehlender Begleitmöglichkeit.
8. Sachverständigengutachten aus Neurologie, Orthopädie und Reha-Technik.
9. Augenschein der Wohn- und Hausausgangssituation, hilfsweise Fotodokumentation und Wohnumfeldbericht.

Eilrechtsschutz

Gesondert ist ein Antrag nach Paragraf 86b SGG zu prüfen. Der Kläger ist ohne geeignete Versorgung aktuell faktisch an die Wohnung gebunden. Es bestehen Sturzgefahr, fehlende sichere Arzt- und Apothekenwege und eine zunehmende Vereinsamung. Die Hauptsache kann nicht ohne erhebliche Nachteile abgewartet werden.

Entwurf Klageerwiderung der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Justitiariat und Prozessabteilung

Stau 35, 26122 Oldenburg

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E-K

Nicht eingereicht. Interner Entwurf der Prozessabteilung vom 08.07.2026.

An das Sozialgericht Oldenburg

In dem Rechtsstreit Heinz Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die begehrte Versorgung mit dem konkret beantragten Elektrorollstuhl.

Keine vollständige Gehunfähigkeit

Aus den Unterlagen folgt keine vollständige Aufhebung der Gehfähigkeit. Der Kläger kann nach dem Facharztbericht in der Wohnung einzelne Wege bewältigen und mit Rollator auf ebener Strecke 32 Meter zurücklegen. Damit liegt keine Situation vor, in der ausschließlich ein Elektrorollstuhl den Basisausgleich leisten kann.

Vorrang einfacher Hilfsmittel

Die Beklagte hat nicht jede Mobilitätsunterstützung abgelehnt. Angeboten wurde die Prüfung eines Standard-Faltrollstuhls. Zudem sind Gehstütze, Rollator, physiotherapeutisches Training und gegebenenfalls wohnumfeldverbessernde Maßnahmen vorrangig zu prüfen. Die gesetzliche Krankenversicherung schuldet keine optimale Versorgung und keine vollständige Kompensation baulicher Hindernisse.

Wirtschaftlichkeit

Der beantragte Elektrorollstuhl kostet 10.990,00 EUR. Ein Standard-Faltrollstuhl aus dem Vertragssortiment ist erheblich günstiger. Der Kläger begehrt eine Versorgung, die auch durch bauliche und soziale Umstände veranlasst ist. Diese Umstände liegen nicht allein im Verantwortungsbereich der Krankenversicherung.

Privates Gutachten

Das private Reha-Gutachten ist nicht neutral. Es wurde vom Kläger beauftragt und ersetzt keine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst. Außerdem bestätigt es, dass der Kläger Transfers durchführen und einzelne Strecken gehen kann. Es belegt daher nicht, dass nur ein Elektrorollstuhl in Betracht kommt.

Fahrsicherheit

Die sichere Bedienung des Elektrorollstuhls ist nicht ausreichend geklärt. Der Kläger ist 78 Jahre alt, sturzgefährdet und herzinsuffizient. Das Rückwärtsfahren wurde im privaten Gutachten als kritisch beschrieben. Bevor eine derart kostenintensive Versorgung bewilligt wird, müsste die Fahrsicherheit belastbar festgestellt werden.

Hilfsweise

Falls das Gericht weiteren Ermittlungsbedarf sieht, wird angeregt, ein unabhängiges Sachverständigengutachten einzuholen und den Medizinischen Dienst um eine persönliche Untersuchung zu ersuchen. Eine Verurteilung unmittelbar zur Versorgung mit dem konkret benannten Modell ist nicht angezeigt.

Gerichtlicher Hinweis und Beweisfragen

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Entwurf richterlicher Hinweis vom 22.07.2026

Vorläufige Einschätzung

Die Kammer weist darauf hin, dass die Sache nicht allein nach der Frage entschieden werden kann, ob der Kläger noch einzelne Schritte zurücklegen kann. Für Paragraf 33 SGB V ist maßgeblich, welches Hilfsmittel im konkreten Einzelfall den Behinderungsausgleich tatsächlich leistet.

Der bisherige Aktenstand enthält Widersprüche:

1. Der Medizinische Dienst sieht Gehstütze, Rollator und Standard-Faltrollstuhl als ausreichend an.
2. Facharzt und privates Reha-Gutachten halten genau diese Hilfsmittel praktisch für ungeeignet.
3. Die Krankenkasse stellt stark auf Kosten ab.
4. Die Klägerseite stellt stark auf Selbständigkeit, Sturzgefahr und Nahbereich ab.

Beweisfragen an einen Sachverständigen

5. Welche objektive Gehfähigkeit besteht bei Heinz Körner innerhalb der Wohnung, im Treppenhaus und im Nahbereich?
6. Kann der Kläger eine Unterarmgehstütze sicher nutzen?
7. Kann der Kläger einen Rollator im tatsächlichen Wohnumfeld sicher nutzen?
8. Kann der Kläger einen Standard-Faltrollstuhl eigenständig und dauerhaft genug antreiben?
9. Ist ein Elektrorollstuhl medizinisch-funktionell erforderlich, um den Basisausgleich der Mobilität im Nahbereich herzustellen?
10. Ist die Bedienung eines Elektrorollstuhls bei langsamer Einstellung und Fahrtraining hinreichend sicher?
11. Gibt es ein gleich geeignetes, wirtschaftlicheres Hilfsmittel?

Hinweise an die Beteiligten

Die Beklagte möge mitteilen, ob sie eine persönliche Begutachtung durch den Medizinischen Dienst veranlasst. Eine reine Aktenlage kann bei streitiger tatsächlicher Mobilität unzureichend sein.

Der Kläger möge eine aktuelle Fotodokumentation von Hauseingang, Abstellfläche, Gehweg und den typischen Nahbereichswegen vorlegen. Außerdem ist darzulegen, ob ein Eilantrag gestellt wird oder ob die Hauptsache vorrangig betrieben werden soll.

Vergleichsfenster

Ein Vergleich könnte lauten:

Die Beklagte bewilligt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine geeignete elektrische Mobilitätsversorgung im Nahbereich nach erneuter technischer Erprobung. Der Kläger nimmt am Fahrtraining teil. Die endgültige Modellauswahl erfolgt durch Vertragssanitätshaus und behandelnden Facharzt. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens werden zur Hälfte übernommen.

Terminsverfügung und Hinweise zur mündlichen Verhandlung

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Schlosswall 16, 26122 Oldenburg

Aktenzeichen: S 12 KR 188/26

Oldenburg, den 25.09.2026

In dem Rechtsstreit Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse wird Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt auf:

Donnerstag, den 22.10.2026, 10.30 Uhr, Sitzungssaal 3.

Hinweise der Kammer

Das eingeholte Sachverständigengutachten vom 16.09.2026 liegt den Beteiligten vor. Die Kammer weist darauf hin, dass sich die Entscheidung maßgeblich auf die dort getroffenen Feststellungen zur Gehstrecke mit Rollator, zur Belastbarkeit beim manuellen Rollstuhlantrieb und zum Ergebnis des Fahrversuchs mit dem Elektrorollstuhl stützen wird.

Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, bis zum Termin ergänzend vorzutragen, insbesondere zu der Frage, ob und in welchem Umfang die im Gutachten beschriebene Erschöpfung bei Nutzung des manuellen Rollstuhls eine dauerhafte, alltagstaugliche Versorgung ausschließt.

Ein Vergleichsvorschlag wurde bislang von keiner Seite unterbreitet. Die Kammer regt an, vor dem Termin zu prüfen, ob eine gütliche Einigung, etwa durch eine testweise Versorgung mit Rückgaberecht, in Betracht kommt.

Ladung der Beteiligten

Geladen werden der Kläger persönlich sowie ein Vertreter der Beklagten mit Entscheidungsbefugnis. Der Sachverständigen wird anheimgestellt, an der Verhandlung teilzunehmen, falls Rückfragen zum Gutachten zu erwarten sind.

Fristenblatt und Anlagenverzeichnis

Fristenblatt

Frist	Berechnung	Ergebnis
Widerspruch gegen Ausgangsbescheid	Bescheid 10.06.2026, Widerspruch 20.06.2026	fristgerecht
Klage gegen Widerspruchsbescheid	Zugang 26.06.2026, Monatsfrist	Ende Montag, 27.07.2026
Kanzlei-Wiedervorlage	sofort nach Mandatierung	03.07.2026
MD-Akte anfordern	Akteneinsicht Verwaltungsvorgang	sofort
Facharzt-Ergänzung	kurze Stellungnahme zu Hilfsmittelalternativen	bis 10.07.2026
Beweisbeschluss Rückfragen	Frist laut gerichtlichem Hinweis	zwei Wochen ab Zustellung
Terminsvorbereitung	vor mündlicher Verhandlung	bis 15.10.2026

Anlagenverzeichnis Klägerseite

Anlage	Dokument
K 1	Bescheid Weser-Ems Gesundheitskasse vom 10.06.2026
K 2	Widerspruch Heinz Körner vom 17.06.2026 (Eingang 20.06.2026)
K 3	Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026
K 4	Überweisung und Hilfsmittelverordnung Dr. Stahlmann
K 5	Facharztbericht Dr. Radtke vom 17.05.2026
K 6	Eigenschilderung Alltag und Wege
K 7	Wohnumfeldbericht RehaTechnik Albrecht
K 8	Kostenvoranschlag RehaTechnik Albrecht vom 20.05.2026
K 9	MD-Stellungnahme vom 05.06.2026
K 10	Privates Reha-Gutachten vom 18.06.2026
K 11	E-Mail Tochter vom 27.06.2026
K 12	Gerichtliches Sachverständigengutachten vom 16.09.2026

Offene Arbeitspunkte

Vor dem Verhandlungstermin sind noch die ergänzende Stellungnahme des Facharztes zur Belastbarkeit beim manuellen Rollstuhlantrieb einzuholen und die Reisekosten des Sachverständigen abzurechnen. Die Kanzlei prüft zudem, ob eine testweise Versorgung mit Rückgaberecht als Vergleichsgrundlage angeboten werden kann.

Ärztliche Verordnung, vollständig ausformuliert

Hausarztpraxis Dr. Eva Stahlmann

Lange Straße 44, 26122 Oldenburg

Verordnung vom 16.05.2026 für Herrn Heinz Körner, geboren 14.03.1948, wohnhaft Theaterwall 62, 26122 Oldenburg.

1. Diagnosen nach ICD-10

ICD-10	Diagnose
M48.06	Spinalkanalstenose, Lumbalbereich
G63.2	Diabetische Polyneuropathie
Z96.64	Zustand nach Hüft-Totalendoprothese links
R26.8	Gangunsicherheit
E11.90	Diabetes mellitus Typ 2 mit diabetischer Polyneuropathie

2. Verordnete Hilfsmittelversorgung

Verordnet wird ein Elektrorollstuhl, kompakte Innenraum- und Nahbereichsausführung, mit Kippschutz, gedrosselter Geschwindigkeit und Fahrtraining. Hilfsmittelnummer nach Produktgruppe 18 des Hilfsmittelverzeichnisses.

3. Begründung des Mobilitätsverlusts

Herr Körner kann im Innenbereich nur wenige Schritte mit Unterarmgehstütze zurücklegen, danach droht Sturzgefahr durch die diabetische Polyneuropathie mit vermindertem Gefühl in beiden Füßen. Der Rollator bietet auf ebener Strecke im Hausflur begrenzte Sicherheit, ist aber auf dem unebenen Gehweg vor dem Haus und beim Überqueren der Bordsteinkante nicht ausreichend sicher nutzbar. Ein manueller Rollstuhl kann von Herrn Körner wegen schmerzhaft eingeschränkter Kraft der rechten Schulter nicht selbstständig angetrieben werden.

4. Behandlungsziel

Ziel der Versorgung ist die Wiederherstellung einer selbstständigen Mobilität im Nahbereich der Wohnung, insbesondere für Arztbesuche, Apothekenwege und den Weg zum Briefkasten, ohne durchgehende Angewiesenheit auf eine Begleitperson.

5. Dringlichkeit

Angesichts wiederholter Stürze in den letzten zwölf Monaten und der zunehmenden sozialen Isolation wird eine zeitnahe Bearbeitung des Antrags dringend angeraten.

Detaillierter Facharztbericht Neurologie

Neurologische Praxis am Pferdemarkt

Dr. Elisabeth Radtke, Fachärztin für Neurologie

Pferdemarkt 12, 26121 Oldenburg

1. Untersuchungsdaten

Untersuchung am 17.05.2026 durch Dr. Elisabeth Radtke, Fachärztin für Neurologie, im Rahmen der Abklärung der Gangstörung und Sturzneigung.

2. Neurologischer Befund

Deutlich reduzierte Vibrationsempfindung beidseits distal betont, abgeschwächte Achillessehnenreflexe beidseits, positiver Romberg-Test mit Fallneigung nach hinten. Gangbild kleinschrittig, breitbasig, mit deutlich verlängerter Standphase.

3. Elektrophysiologische Zusatzdiagnostik

Nervenleitgeschwindigkeitsmessung bestätigt eine sensomotorische Polyneuropathie beider Beine, vereinbar mit der bekannten diabetischen Genese. Die Befunde erklären die verminderte Standfestigkeit und die erhöhte Sturzgefahr insbesondere auf unebenem Untergrund.

4. Funktionelle Einschätzung

Die Gehstrecke ohne Hilfsmittel liegt unter 10 Metern, mit Unterarmgehstütze bei kontrollierten Bedingungen bei etwa 15 Metern, jedoch mit deutlich erhöhtem Sturzrisiko bei Richtungswechseln oder Bodenunebenheiten. Aus neurologischer Sicht ist die vorhandene Restgehfähigkeit für eine sichere Alltagsmobilität im Außenbereich nicht ausreichend.

5. Fachärztliche Empfehlung

Aus neurologischer Sicht wird eine Versorgung mit einem sturzsicheren, selbstständig zu bedienenden Mobilitätshilfsmittel für den Nahbereich empfohlen. Ein Elektrorollstuhl mit Kippschutz und gedrosselter Geschwindigkeit erscheint geeignet, sofern ein Fahrtraining die kognitive und motorische Eignung bestätigt.

Ergotherapeutischer Bericht

Ergotherapie Nordwest

Praxis für Ergotherapie, Melanie Bruns

Nadorster Straße 60, 26123 Oldenburg

1. Behandlungsauftrag

Ergotherapeutische Befunderhebung im Auftrag des Hausarztes zur Beurteilung der Alltagskompetenz und Handlungsfähigkeit von Herrn Heinz Körner, Behandlung vom 20.05.2026 bis 03.06.2026, insgesamt vier Termine.

2. Befunderhebung Alltagsaktivitäten

Transfer Bett zu Rollstuhl gelingt mit Anleitung und Haltegriff, benötigt jedoch mehr Zeit als altersüblich. Greiffunktion beider Hände eingeschränkt durch verminderte Sensibilität, feinmotorische Aufgaben wie das Bedienen eines Schlüssels gelingen verlangsamt.

3. Beobachtung im häuslichen Umfeld

Beim Hausbesuch am 27.05.2026 zeigte sich, dass Herr Körner die Wohnungstür nur mit Mühe selbstständig öffnen kann, wenn er sich gleichzeitig am Rollator festhalten muss. Die Küchenarbeitsfläche ist im Stehen nur kurzzeitig nutzbar.

4. Einschätzung zur Hilfsmittelnutzung

Ein Elektrorollstuhl würde die Hände für Greif- und Bedienaufgaben freihalten, während Gehstock und Rollator beide Hände zur Stabilisierung binden. Dies ist für die Verrichtung alltäglicher Handlungen wie Türöffnen, Briefkasten leeren oder Einkaufstasche tragen von Bedeutung.

5. Empfehlung

Aus ergotherapeutischer Sicht wird die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl befürwortet, verbunden mit einem strukturierten Bedienungstraining über vier bis sechs Einheiten.

Physiotherapeutischer Bericht

Physiotherapie Am Stadtwall

Praxis Timo Elsholz

Stau 15, 26122 Oldenburg

1. Behandlungsverlauf

Physiotherapeutische Behandlung seit Januar 2026, zweimal wöchentlich, Schwerpunkt Gangschulung, Gleichgewichtstraining und Kräftigung der Beinmuskulatur nach Hüft-TEP links.

2. Aktueller Trainingsstand

Trotz regelmäßiger Übungsbehandlung konnte die Gehstrecke in den letzten sechs Monaten nicht wesentlich gesteigert werden. Die Standsicherheit bleibt durch die diabetische Polyneuropathie limitiert, das Sturzrisiko wird durch Übungen nur bedingt reduziert.

3. Sturzereignisse im Behandlungszeitraum

Nach Angaben des Patienten kam es im Behandlungszeitraum zu drei Stürzen, davon zwei im Wohnungsflur und einer auf dem Gehweg vor dem Haus, jeweils ohne schwere Verletzungsfolgen, jedoch mit zunehmender Sturzangst.

4. Physiotherapeutische Einschätzung

Eine weitere Verbesserung der Gehfähigkeit über das aktuelle Niveau hinaus ist nach fachlicher Einschätzung nur eingeschränkt zu erwarten, da die zugrunde liegende Polyneuropathie nicht reversibel ist. Die Fortführung der Physiotherapie dient dem Erhalt der Restmobilität, ersetzt aber keine geeignete Hilfsmittelversorgung für den Nahbereich außerhalb der Wohnung.

Wohnungs-Rundgang-Protokoll mit Skizzenbeschreibung

RehaTechnik Albrecht GmbH

Fachhandel für Rehabilitationstechnik

Donnerschweer Straße 188, 26123 Oldenburg

1. Termin und Anwesende

Hausbesuch am 19.05.2026 durch den Rehatechniker Jonas Wiechmann. Anwesend waren Herr Körner und seine Tochter Frau Maren Körner.

2. Raumbeschreibung mit Maßangaben

Bereich	Masse und Beschaffenheit	Bewertung für Elektrorollstuhl
Hauseingang	Vordereingang mit 14 und 16 cm hohen Stufen	Rampe oder Treppenlift erforderlich, gesondert zu prüfen
Treppenhaus zur Wohnung im ersten Obergeschoss	Breite ca. 108 cm, kein Aufzug ins erste Obergeschoss	Elektrorollstuhl bleibt im Erdgeschoss, Transferlösung nötig
Wohnungsflur	Breite 95 cm, ein Wandvorsprung	Geräteabmessung, Türöffnung und Wendezone prüfen
Wohnzimmer	18 Quadratmeter, ein Teppich mit erhöhter Kante	Teppichkante zu entfernen oder abzuflachen
Küche	schmal, Arbeitsfläche 60 cm Durchgangsbreite	eingeschränkt befahrbar, Rangieren erschwert
Badezimmer	lichte Türbreite ca. 68 cm, keine Schwellenfreiheit	nicht mit Elektrorollstuhl befahrbar, Rollator im Bad erforderlich

3. Skizzenbeschreibung

Für das Aufmaß wurde eine Handzeichnung verwendet. Erfasst wurden der Hauseingang, die Treppe, die Wohnungstür und die Übergänge zu Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Bad. Die Maße in der Tabelle sind die übertragenen Messwerte.

4. Außenbereich

Der Gehweg vor dem Haus ist asphaltiert, weist jedoch nach 40 Metern eine abgesenkte, aber leicht schräge Bordsteinkante zur Querungshilfe auf. Die nächste Apotheke liegt in etwa 180 Metern Entfernung, der Hausarzt in etwa 600 Metern.

5. Fazit des Rehatechnikers

Für den Innenbereich der Wohnung sowie den unmittelbaren Nahbereich nach Überwindung der Eingangsstufen ist ein kompakter Elektrorollstuhl technisch geeignet. Die beiden Eingangsstufen erfordern zusätzlich eine mobile Rampe oder einen baulichen Umbau, der gesondert bei der Pflegekasse zu beantragen wäre.

Kostenvoranschlag mit Alternativen, vollständige Fassung

RehaTechnik Albrecht GmbH

Fachhandel für Rehabilitationstechnik

Donnerschweer Straße 188, 26123 Oldenburg

Kostenvoranschlag Nr. RTA-2026-3381 vom 20.05.2026

1. Hauptangebot: Kompakter Elektrorollstuhl

Position	Bezeichnung	Einzelpreis EUR
1	Elektrorollstuhl Innenraum- und Nahbereichsklasse B	8990.00
2	Kippschutz hinten	310.00
3	Zusatzakku für erweiterte Reichweite	540.00
4	Fahrtraining, sechs Einheiten	480.00
5	Anpassung Sitzsystem	670.00

Gesamtsumme Hauptangebot: 10990.00 EUR

2. Alternative 1: Aufsatz-Antrieb für vorhandenen Faltrollstuhl

Ein elektrischer Zusatzantrieb, der auf den bereits vorhandenen manuellen Faltrollstuhl aufgesetzt wird, käme auf etwa 4200.00 EUR. Diese Lösung würde die Anschaffung eines komplett neuen Rollstuhls vermeiden, ist jedoch technisch nur eingeschränkt für die schmalen Innenräume der Wohnung geeignet, da sich die Gesamtbreite des Systems um zusätzliche 12 Zentimeter vergrößert.

3. Alternative 2: Standard-Elektrorollstuhl ohne Sonderausstattung

Ein einfacheres Modell ohne Zusatzakku und ohne individuelle Sitzanpassung würde etwa 6100.00 EUR kosten, würde nach fachlicher Einschätzung des Sanitätshauses jedoch die notwendige Reichweite für den täglichen Weg zur Apotheke und zum Hausarzt nicht zuverlässig gewährleisten.

4. Vergleich mit dem von der Kasse favorisierten Standard-Faltrollstuhl

Ein Standard-Faltrollstuhl aus dem Vertragssortiment der Krankenkasse liegt bei etwa 740.00 EUR, setzt aber durchgehend eine schiebende Begleitperson voraus und stellt keine selbstständige Mobilität her.

5. Empfehlung des Sanitätshauses

Aus fachlicher Sicht wird das Hauptangebot empfohlen, da es die einzige Option ist, die sowohl den räumlichen Anforderungen der Wohnung als auch der erforderlichen Reichweite für den Nahbereich gerecht wird.

Vergleichsangebot der Krankenkasse, Standardmodell

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungsabteilung Hilfsmittel

Stau 35, 26122 Oldenburg

Schreiben vom 09.06.2026 an das Sanitätshaus RehaTechnik Albrecht GmbH, zur Kenntnis an den Versicherten.

1. Angebot der Kasse

Die Weser-Ems Gesundheitskasse bietet im Rahmen ihres Vertragssortiments einen Standard-Faltrollstuhl zum Vertragspreis von 740.00 EUR sowie ergänzend eine Unterarmgehstütze zum Preis von 38.00 EUR an. Beide Hilfsmittel seien im Hilfsmittelverzeichnis unter Produktgruppe 18 und 22 gelistet und aus Sicht der Kasse ausreichend.

2. Begründung der Kasse

Nach der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 05.06.2026 bestehe eine Restgehfähigkeit, die in Verbindung mit einem Rollator und einem Faltrollstuhl für Begleitwege ausreiche. Die Kasse verweist auf das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Paragraf 12 SGB V.

3. Rückmeldung des Leistungserbringers

Rückmeldung des Sanitätshauses erbeten. Liefertermin, Rahmenabmessungen und Greifreifenlage eines zum Versicherten passenden Geräts sind vor einer Auslieferung zu klären. Eine Erprobung im Gebäude ist im Angebot noch nicht terminiert.

Antrag auf Einholung eines Zweitgutachtens

Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Fachanwälte für Sozialrecht, Oldenburg

Bearbeiter: Rechtsanwalt Joost Ahlers

Staulinie 8, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 77 03 30, Telefax 0441 77 03 39

USt-IdNr. DE 812 447 903

An die Weser-Ems Gesundheitskasse, Leistungsabteilung Hilfsmittel, Schreiben vom 22.06.2026.

1. Antrag

Namens des Herrn Heinz Körner wird beantragt, vor abschließender Entscheidung über den Widerspruch ein unabhängiges Zweitgutachten einzuholen, das auf einer persönlichen Untersuchung und einer praktischen Erprobung des beantragten Elektrorollstuhls im Wohnumfeld beruht.

2. Begründung

Die bisherige Stellungnahme des Medizinischen Dienstes beruht ausschließlich auf Aktenlage, ohne eigene körperliche Untersuchung, Gehprobe oder Erprobung der in Betracht kommenden Hilfsmittel. Demgegenüber stützt sich das private Gutachten von RehaTechnik Albrecht auf eine mehrstündige praktische Erprobung im tatsächlichen Wohnumfeld. Angesichts dieser Diskrepanz erscheint eine erneute, unabhängige Begutachtung sachgerecht.

Es wird angeregt, mit der Begutachtung eine Fachärztin oder einen Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin zu beauftragen, die oder der weder für die Krankenkasse noch für den Kläger bereits tätig geworden ist.

Herrn Heinz Körner
Theaterwall 62 · 26122 Oldenburg
Oldenburg, 24. Juni 2026 · HM-2026-7714-E-W

Widerspruchsbescheid

1 Entscheidung

Der Widerspruch vom 17. Juni 2026, eingegangen am 20. Juni 2026, gegen den Bescheid vom 10. Juni 2026 wird zurückgewiesen. Notwendige Aufwendungen des Widerspruchsverfahrens werden nicht erstattet.

2 Gegenstand des Verfahrens

Sie beantragten am 22. Mai 2026 eine Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl für Innenräume und Wege im Nahbereich. Der Antrag nimmt Bezug auf die Verordnung von Dr. Eva Stahlmann vom 16. Mai und auf das Angebot des Sanitätshauses vom 20. Mai. Eine auf ein bestimmtes Fabrikat beschränkte Versorgung haben Sie weder im Antrag noch im Widerspruch verlangt. Das vorliegende Angebot über 10.990 Euro brutto dient uns als Grundlage für die Beurteilung des beantragten technischen Funktionsumfangs.

Der Medizinische Dienst hat am 5. Juni nach Aktenlage Stellung genommen. Mit Bescheid vom 10. Juni haben wir die beantragte elektrische Versorgung abgelehnt. Das Angebot, im Vertragssortiment einen Standard-Faltrollstuhl erproben zu lassen, bleibt bestehen. Eine Leistung für einen baulichen Umbau ist durch den Bescheid vom 10. Juni nicht geregelt. Ihr Einwand, Sie könnten mit dem Rollator keine öffentlichen Wege mehr allein erledigen, ist in die Überprüfung einbezogen worden.

3 Zulässigkeit

Ihr Widerspruch ist zulässig. Das Schreiben ist unterschrieben, nimmt eindeutig auf den bezeichneten Ausgangsbescheid Bezug und ging innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe ein. Eine persönliche Vorsprache ist für die Wirksamkeit nicht erforderlich. Für die Prüfung der Sache ist die Widerspruchsstelle der Weser-Ems Gesundheitskasse zuständig.

4 Begründung der Entscheidung

4.1 Erforderlichkeit einer Hilfsmittelversorgung

Nach Paragraf 33 Absatz 1 SGB V besteht ein Anspruch auf Hilfsmittel zum Ausgleich einer Behinderung, soweit die Versorgung im Einzelfall erforderlich ist. Sie muss nach Paragraf 12 Absatz 1 SGB V ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Wir gehen davon aus, dass eine erhebliche Gehbeeinträchtigung vorliegt. Über die beantragte Ausführung ist anhand des konkreten Zugewinns gegenüber den im Einzelfall nutzbaren Alternativen zu entscheiden. Der Medizinische Dienst berät die Kasse. Seine Stellungnahme dient der Feststellung medizinischer und funktioneller Umstände. Die Leistungsentscheidung trifft die Kasse.

4.2 Bedeutung der Gehproben

Die hausärztliche Untersuchung dokumentiert den Abbruch einer Strecke von 18 Metern mit Unterarmgehstütze. Der Facharzt beschreibt 14 Meter mit dieser Stütze sowie 32 Meter auf ebener Fläche mit einem Rollator unter Aufsicht. Diese Messungen sprechen für eine erhebliche Belastungsgrenze. Sie lassen auch erkennen, dass die Gehhilfen für einzelne wohnungsnahe Teilstrecken eingesetzt werden können. In Ihrer Schilderung sind Haltepunkte an Möbeln und eine Sitzmöglichkeit im Flur genannt. Ob diese Gehfähigkeit durch Gangschulung stabilisiert werden kann,

hat der Medizinische Dienst nicht am Ort untersucht. Er empfiehlt, die vorhandenen Mittel im Rahmen der sicher möglichen Anwendung weiter zu nutzen.

4.3 Privater Erprobungsbericht

Wir haben den Bericht von Herrn Falke vom 18. Juni berücksichtigt. Er dokumentiert den Fahrversuch vom Vortag, die Lenkabweichung beim Standard-Faltrollstuhl und die sichere Bremsung des kompakten Elektrorollstuhls im Innenhof. Die Beobachtung gibt Aufschluss über die Bedienung der jeweils eingesetzten Geräte unter den dokumentierten Bedingungen. Sie enthält weder einen Vergleich mit einem angepassten manuellen Aktivrollstuhl noch eine abgeschlossene Erprobung im öffentlichen Verkehrsraum. Die Ergebnisse rechtfertigen aus unserer Sicht eine Überprüfung möglicher Versorgungsformen, belegen aber noch nicht die durchgängige Eignung der beantragten Ausführung.

Wir entnehmen dem Bericht, dass Ihre Tochter Ihnen für einen Teil der Wege helfen kann. Für den Treppenabschnitt ist unabhängig vom konkret beantragten Rollstuhl weiterhin Hilfe erforderlich. Die Häufigkeit, mit der eine Begleitperson tatsächlich zur Verfügung steht, wurde im Bericht nur aus den Angaben der Familie übernommen. Die Widerspruchsstelle hat hierzu keine eigene Erhebung vorgenommen.

4.4 Abstellort und Zugang zur Straße

Die Hausverwaltung hat mitgeteilt, dass das Gerät im Rettungsweg nicht aufgestellt werden darf. Der abschließbare Raum neben dem Hofausgang kommt nach einer technischen Prüfung in Betracht. Eine abschließende Freigabe für die Nutzung oder das Laden liegt uns bislang nicht vor. Die hintere Tür öffnet aus dem Hof nicht selbsttätig. Ob Sie die Bedienung im Sitz mit der vorgesehenen Steuerung und einer geeigneten Türhilfe bewältigen, lässt sich aus der Geradeausfahrt im Hof nicht ableiten. Der Rollstuhl kann die Treppe vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss selbst nicht überwinden.

4.5 Prüfung der Alternativen und Kosten

Die Kombination aus vorhandener Gehhilfe und Faltrollstuhl erscheint uns für Teilstrecken und begleitete Wege zunächst ausreichend. Der Vertragspreis für einen Standard-Faltrollstuhl beträgt nach Mitteilung des Leistungserbringers ungefähr 740 Euro. Wir erkennen an, dass dieser Preis allein eine funktionelle Gleichwertigkeit nicht belegt. Bei dem Versuch im Hof wurde ein vorgehaltenes Standardgerät ohne individuelle Anpassung benutzt. Ein Gerät aus dem Vertragssortiment mit überprüfter Sitzbreite und erreichbaren Greifreifen ist noch nicht erprobt worden. Solange der praktische Zugewinn für regelmäßig erreichbare Nahbereichswege und die Eignung einer günstigeren Alternative offen sind, sehen wir die beantragte elektrische Vollversorgung nicht als hinreichend belegt an.

4.6 Ihr Antrag auf weitere Untersuchung

Das Schreiben vom 22. Juni regt eine persönliche Begutachtung und einen Vergleich der Versorgungsformen vor Ort an. Eine weitere Begutachtung ist vor der heutigen Entscheidung nicht erfolgt. Wir halten die vorhandenen ärztlichen und technischen Angaben für ausreichend, um über das bisher konkretisierte Begehren zu entscheiden. Sollte ein aktueller Erprobungsbericht die Nutzbarkeit des Hofwegs und die Möglichkeiten eines geeigneten Vergleichsgeräts genauer klären, prüfen wir auf Ihre Mitteilung hin den dann vorliegenden Sachstand.

5 Kosten und Rechtsbehelf

Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraf 63 SGB X. Ihr Widerspruch hatte keinen Erfolg.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Oldenburg, Schlosswall 16, 26122 Oldenburg, erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, in der gesetzlich vorgesehenen elektronischen Form oder zu Protokoll der Geschäftsstelle erhoben werden. Für die elektronische Übermittlung gelten die Anforderungen des Paragrafen 65a SGG.

Für die Widerspruchsstelle

Ute Kelling

An das Sozialgericht Oldenburg
Schlosswall 16 · 26122 Oldenburg
Per beA · Oldenburg, 3. Juli 2026 · Kanzleizeichen 26-06-KR-1187

Klageschrift

Namens und in Vollmacht des Herrn Heinz Körner, Theaterwall 62, 26122 Oldenburg, erheben wir Klage gegen die Weser-Ems Gesundheitskasse, Stau 35, 26122 Oldenburg, vertreten durch ihren Vorstand.

1 Anträge

Wir beantragen, den Bescheid vom 10. Juni 2026 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24. Juni 2026 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, den Kläger mit einem zur selbstständigen Erschließung des Nahbereichs geeigneten kompakten Elektrorollstuhl mit individuell angepasstem Sitz, rechtsseitiger Bedienung, erforderlichem Kippschutz und Beleuchtung sowie einer Einweisung am Einsatzort zu versorgen. Die konkrete Modellwahl kann nach praktischer Erprobung im Gebäudezugang und auf typischen Nahbereichswegen erfolgen. Die Überlassung eines geeigneten Wiedereinsatzgeräts kommt in Betracht. Die Kostenentscheidung wird nach Paragraf 193 SGG beantragt.

2 Verfahrensstand und Zulässigkeit

Der Kläger beantragte die Sachleistung am 22. Mai 2026. Die Beklagte lehnte sie am 10. Juni ab. Der Kläger verfasste seinen Widerspruch am 17. Juni eigenhändig. Der Eingangsstempel weist den 20. Juni aus. Der Widerspruchsbescheid wurde dem Kläger am 26. Juni zugestellt. Die Klage vom 3. Juli liegt damit vor Ablauf der Monatsfrist der Paragrafen 64 und 87 SGG. Die kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage nach Paragraf 54 Absatz 1 und Absatz 4 SGG ist statthaft. Der Kläger hat das angebotene Gerät nicht gekauft. Er verlangt eine Versorgung durch die Beklagte und keine Erstattung selbst aufgewendeter Kosten.

Der Streitgegenstand umfasst die vom Leistungsantrag und den beiden Bescheiden erfasste Hilfsmittelversorgung. Ein Umbau des Treppenhauses oder ein Zuschuss für eine feste Rampe wird nicht beantragt. Der Sachverhalt zur baulichen Erreichbarkeit ist dennoch wichtig, weil sich daran die tatsächliche Nutzbarkeit des Hilfsmittels entscheidet. Eine bauliche Maßnahme wäre mit dem Vermieter und gegebenenfalls der Pflegekasse gesondert zu klären.

3 Tatsächliche Ausgangslage

3.1 Wohnen und verfügbare Hilfe

Der 78-jährige Kläger lebt allein im ersten Obergeschoss eines Altbaus. Seine Tochter Maren unterstützt ihn bei Arztterminen und Einkäufen, wenn ihr Schichtdienst es erlaubt. Einen festen täglichen Begleitdienst gibt es nicht. Die Bewohner des Hauses helfen gelegentlich, wenn sie die Bitte hören oder jemanden treffen. Der Kläger kann diese Hilfe weder kurzfristig bestellen noch für den Rückweg verbindlich einplanen. In den letzten Monaten wurden deshalb kurze Erledigungen zu einer Angelegenheit für mehrere Personen. Bei einem Arzttermin musste die Tochter ihn vom Treppenabsatz abholen, nach unten begleiten und später für den Rückweg an derselben Stelle bereitstehen.

Das erste Obergeschoss ist über 15 Stufen erreichbar. Der in einem früheren Wohnbericht als Aufzug bezeichnete Plattformlift im Hochparterre überwindet lediglich den dortigen Niveauunterschied zum Hofsteg. Er erschließt die Wohnung nicht. Der Kläger will das Gerät unten abstellen. Die Hausverwaltung hat den Rettungsweg als Abstellort ausgeschlossen und stattdessen einen

abschließbaren ehemaligen Trockenraum neben der Hoftür zur technischen Prüfung benannt. Die Stromfreigabe steht noch aus. Die bisherige Hilfe auf der Treppe bleibt erforderlich. Der Kläger verlangt, dass der Versorgungsversuch nach Möglichkeit den Übergang von der begleiteten Treppe zur eigenständigen Nutzung ab Erdgeschoss abbildet.

3.2 Erkrankungen und Beobachtungen im Alltag

Die dokumentierten Funktionsstörungen beruhen auf lumbaler Spinalkanalstenose, diabetischer Polyneuropathie, eingeschränkter kardialer Belastbarkeit, Beschwerden der rechten Schulter und den Folgen einer Hüfttotalendoprothese links. Der Kläger kann sich im Zimmer umsetzen und auf glatter Fläche unter Aufsicht kurze Strecken zurücklegen. Im Freien muss er Gehwegkanten erkennen, die Blickrichtung von den Füßen lösen, die Richtung wechseln und notfalls abrupt stehen bleiben. Die Standschwäche tritt besonders bei dieser Kombination auf. Die Schulterbeschwerden treten beim wiederholten Ziehen und Schieben am Greifreifen zusätzlich auf.

Die Praxis von Dr. Eva Stahlmann beobachtete am 16. Mai einen Abbruch nach 18 Metern mit Unterarmgehstütze, deutliche Atemnot und einen Puls von 118 pro Minute. Dr. Malte Radtke erhob am 17. Mai auf ebenem Flur 14 Meter mit Stütze und 32 Meter mit Rollator bei Sicherung. Diese Werte beschreiben unterschiedliche Bedingungen. Sie ergeben weder eine allgemein verfügbare Gehstrecke noch die Fähigkeit, nach einem Einkauf oder einem Termin die Strecke zurückzugehen. Für die Leistungsbeurteilung kommt es deshalb auch darauf an, wie oft die Strecke wiederholt werden kann und was auf dem Rückweg passiert.

3.3 Konkrete Ziele

Die Hausarztpraxis liegt etwa 260 Meter, die Apotheke etwa 310 Meter und der Bäcker rund 420 Meter entfernt. Die von der Familie aufgenommenen Entfernungen bezeichnen einfache Wege ab Haus. Der übliche Weg zur Apotheke führt an einem abgesenkten Bordstein und über einen unterschiedlich befestigten Gehweg. Vor der Apotheke muss die Eingangssituation gesondert betrachtet werden. Der Supermarkt liegt etwa 650 Meter entfernt und wird wegen des Rückwegs mit Einkauf derzeit nur mit Unterstützung erreicht. Der weiter entfernte Friedhof ist ein persönlicher Wunsch. Der Leistungsantrag stützt sich bereits auf die regelmäßig wiederkehrenden Wege zu Arzt, Apotheke und Grundversorgung. Auch wenn der Friedhof nicht einbezogen wird, bleibt der Kernbedarf bestehen.

3.4 Technische Erprobung

Bei der Erprobung am 18. Mai konnte der Kläger mit dem Standard-Faltrollstuhl 12 Meter auf trockener Fläche zurücklegen. Die linke Seite blieb zurück. Nach deutlichem Gegenlenken rechts gab der Kläger Schulterbeschwerden an. Die Tochter schob den Rollstuhl zurück. Mit dem elektrisch gesteuerten Gerät fuhr er nach Einweisung den 78-Meter-Kurs, hielt kontrolliert an und wendete langsam. Ein Korrekturhinweis beim Rückwärtsfahren war erforderlich. Der Versuch dokumentiert eine unterschiedliche Bedienbarkeit unter vergleichbaren Hofbedingungen. Eine Freigabe für Straßenquerungen ergibt sich daraus noch nicht.

Herr Falke wiederholte die Funktionsprüfung am 17. Juni. Auf dem Gehweg brach er den Rollatorversuch vor Überwindung der Kante ab. Beim manuellen Stuhl beobachtete er erneut, dass der Kläger nicht geradeaus fuhr. Die Joysticksteuerung rechts ermöglichte nach Einstellung des Geschwindigkeitsprofils kontrollierte Richtungswechsel. Der Bericht unterscheidet die Möglichkeit des Antriebs von der Sicherheit des konkreten Zugangs. Diese Unterscheidung sollte auch der gerichtlichen Beweisaufnahme zugrunde gelegt werden.

3.5 Angaben der Beklagten zur Vergleichsversorgung

Die Beklagte hat am 9. Juni einen Standard-Faltrollstuhl zum Vertragspreis von ungefähr 740 Euro und eine Unterarmgehstütze genannt. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, welcher Rahmen, welche Sitzbreite und welcher Greifreifenabstand für den Kläger bereitgestellt werden können. Ein eigener Probebetrieb mit dem Vertragshilfsmittel im Wohnumfeld ist bisher nicht dokumentiert. Der Kläger hat am 17. Juni erklärt, dass er zu einer solchen Prüfung bereit ist. Bei einem geeignet angepassten Gerät kann die Prüfung auch ergeben, dass eine wirtschaftlichere Lösung gleich wirksam ist. Der Kläger verlangt eine vergleichbare praktische Erprobung, solange die Beklagte sich auf diese Möglichkeit stützt.

4 Rechtliche Würdigung

4.1 Behinderungsausgleich im konkreten Nahbereich

Anspruchsgrundlage ist Paragraf 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V in der Alternative des Behinderungsausgleichs. Die begehrte Versorgung soll die Folgen der beeinträchtigten Gehfähigkeit bei der eigenständigen Bewegung ausgleichen. Ein Elektrorollstuhl dieser Art dient einem spezifischen medizinisch-funktionellen Zweck. Dass auch ein Spaziergang möglich werden kann, ändert die hier maßgebliche Zweckbestimmung für regelmäßig erforderliche Wege nicht.

Das Bundessozialgericht beurteilt den Nahbereich anhand der realen Versorgungs- und Gesunderhaltungswege des Versicherten und ihrer zumutbaren Bewältigung. Für motorunterstützte Mobilitätshilfen unterscheidet es den grundsätzlichen Zweck der Erschließung von der Frage, welche Technik im Einzelfall erforderlich ist. Maßgeblich sind unter anderem Körperkraft, Gesundheitszustand, Umgebung und die praktisch vergleichbare Nutzung einer Alternativversorgung. Wir verweisen auf BSG, Urteil vom 18. April 2024, B 3 KR 14/23 R, Randnummern 24 bis 29. Die Entscheidung betrifft ein Rollstuhlzuggerät. Übertragbar ist der Prüfmaßstab, dass ein wesentlicher Teil der Alltagswege sicher und zumutbar erschlossen werden können muss. Eine starre Mindestdistanz oder die Voraussetzung einer vollständigen Gehunfähigkeit folgt daraus nicht.

Die Beklagte erfasst die Restfunktion zutreffend als Teil der Ausgangslage. Sie gibt der Restfunktion in der Schlussfolgerung jedoch eine Reichweite, die in den Originalbefunden nicht gemessen wurde. Der Unterschied zwischen beaufsichtigten 32 Metern im Flur und einem selbstständigen Arztweg von mindestens 520 Metern hin und zurück ist gerade der Gegenstand der Versorgung. Eine Schlussfolgerung, die nur die Tatsache einer zurückgelegten Teilstrecke übernimmt, lässt Wendung, Halt, Rückweg und fehlende Begleitperson außer Betracht.

4.2 Wirtschaftlichkeit und Ausstattung

Nach Paragraf 12 Absatz 1 SGB V ist eine geeignete wirtschaftlichere Versorgung vorrangig. BSG, Urteil vom 18. April 2024, B 3 KR 13/22 R, vergleicht zwei technische Systeme anhand ihrer jeweiligen Bedienung und der gesundheitlichen Folgen. Dort ging es um ein motorunterstütztes Zuggerät und eine andere Form der Kraftunterstützung. Auf den hiesigen Fall übertragbar ist die Bedeutung einer funktionsbezogenen Gegenüberstellung. Aus dem Urteil ergibt sich keine Verpflichtung der Beklagten, ein bestimmtes Modell oder jede angebotene Zusatzposition zu bezahlen.

Beim Kläger kommen der Bedarf an Rumpfstabilisierung, die Wahl eines rechtsseitigen Joysticks, die Schwellenfahrt und die sichere Einweisung als technische Auswahlkriterien in Betracht. Die Reichweite ist anhand der tatsächlich relevanten Strecken und des Einsatzprofils zu bestimmen. Für einen Zusatzakku ist bisher kein selbstständiger medizinischer Bedarf bewiesen. Ebenso ist zu prüfen, ob der im Angebot gesondert angesetzte Bordsteinassistent erforderlich ist, wenn der Hofweg mit gesicherter Schwellenhilfe benutzt werden kann. Der Kläger hat ein Interesse an einer sachgerechten

bedarfsgerechten Versorgung. Komfort und zusätzliche Freizeitreichweite sind nicht Gegenstand des Antrags.

Das preislich günstige Standardgerät kann sinnvoll sein, wenn es im konkreten Fall den Bedarf ebenso deckt. Die Beklagte hat bisher nur die hypothetische Anpassbarkeit und die Möglichkeit gelegentlicher Begleitung angeführt. Gelegentliche Begleitung des Wegs bis zum Abstellraum kann mit einem Elektrorollstuhl die anschließende Mobilität wesentlich erweitern. Sie ist etwas anderes als eine Schiebehilfe für den gesamten Weg samt Wartezeiten und Rückfahrt. Ein Aufsatzantrieb wäre anhand seines Bedienkonzepts zu prüfen. Wenn er nur über Greifreifenimpulse aus der betroffenen Schulter oder durch eine Begleitperson gesteuert werden kann, trägt die niedrigere Anschaffungssumme den Versorgungsvergleich nicht. Eine seitliche Verbreiterung wäre an der hinteren Tür und am Abstellraum im funktionsfertigen Zustand zu messen.

4.3 Erreichbarkeit und Fahrsicherheit

Der Kläger unterschätzt die Bedeutung des Wohnumfelds nicht. Ohne einen nutzbaren Abstellraum und einen Zugang zur Straße kann eine erfolgreiche Hofprobe im Alltag folgenlos bleiben. Der Stand der Hausverwaltung rechtfertigt eine gerichtliche Sachaufklärung über den verfügbaren Platz und die praktische Benutzbarkeit. Er rechtfertigt für sich genommen keine Verurteilung zur Lieferung an einen verbotenen Standort. Mit der bereits benannten konkreten Alternative und einer vereinbarten Ortsprobe besteht aber eine nachvollziehbare Perspektive, die geprüft werden kann. Der Kläger ist zu einer Anpassung, Übungsfahrt und Begrenzung der Geschwindigkeit bereit. Der Nachweis einer sicheren Bedienung soll sich auf die tatsächliche Tätigkeit beziehen und die beobachtete Unsicherheit beim Rückwärtsfahren ausdrücklich mitbewerten.

4.4 Bedeutung der Begleit und Transportangebote

Die Beklagte hat keine bestimmte Person oder Einrichtung benannt, die den Kläger in der erforderlichen Häufigkeit vom Treppenabsatz bis zum jeweiligen Ziel schiebt und die Rückkehr absichert. Dass die Tochter ihn bei einzelnen Arztterminen mit dem Auto mitnimmt, ist unstreitig. Ein solcher Termin sagt nichts über die Möglichkeit aus, außerhalb einer verabredeten Fahrt selbst den Briefkasten aufzusuchen oder in die Apotheke zu gehen. Eine praktische Versorgungslösung kann die begrenzte Hilfe beim Treppenabschnitt einbeziehen. Sie muss aber den eigenständigen Handlungsspielraum ab dem Erdgeschoss anhand des konkreten Weges prüfen. Wenn nur die Abfahrt in einem Kraftfahrzeug erprobt wird, bleiben Anfahren, Wenden, Bremsen und Türöffnung auf dem Gehweg unbeantwortet.

Die Beurteilung der Erforderlichkeit ist von der Frage zu trennen, wie die Versorgung umgesetzt wird. Für die beantragte Sachleistung kann eine Lieferung nach erfolgreicher Einweisung und objektiv beschriebener Ortsprüfung sachgerecht sein. Der Kläger ist bereit, eine anfängliche Geschwindigkeitsbegrenzung und eine Nachkontrolle zu vereinbaren. Ein befristeter leihweiser Einsatz kann die offenen Fragen zur Regelmäßigkeit des Nutzens klären. Eine unangepasste Probefahrt auf einem Klinikflur allein würde dafür nicht genügen. Es sollten Hin- und Rückweg, nötige Hilfe und konkrete Abbrüche protokolliert werden.

5 Beweisangebote und Aktenanforderung

Zum Nachweis der Verwaltungsdaten beantragen wir die vollständige Beiziehung der Leistungs- und Widerspruchsakte einschließlich Eingangsbuch, Prüfanfrage an den Medizinischen Dienst, übermittelter Anlagen und des Vertragsangebots. Ob alle Befunde zum Zeitpunkt der Stellungnahme vorlagen, ergibt sich weder aus dem Ausgangsbescheid noch aus einer kurzen Aktenliste zuverlässig.

Zum Nachweis der beobachteten Geh- und Antriebsgrenzen regen wir eine unabhängige rehabilitationsmedizinische Begutachtung an. Die Ärztin oder der Arzt sollte die Probe mit Rollator und einem individuell einstellbaren manuellen Gerät wiederholen, Pausen, Stabilisierung, Beschwerden und Hilfestellung dokumentieren und die Bedingungen der Versuche ausdrücklich benennen. Zu prüfen ist ferner, ob mit rechtsseitiger Bedienung ein gedrosseltes Gerät nach Einweisung in einer für das Wohnumfeld aussagefähigen Weise sicher geführt werden kann.

Für die tatsächliche Begleitung auf der Treppe und die Häufigkeit der Hilfe bieten wir Maren Körner als Zeugin an, ladungsfähig über die Kanzlei. Zu Tür, Ladeplatz, Stromversorgung und Hauszugang bieten wir Zeugnis der Hausverwalterin Gesa Lübben sowie die technische Ortsbesichtigung an. Für die tatsächlichen Beobachtungen am 18. Mai und 17. Juni benennen wir Anja Voss und Sven Falke. Die Anregung betrifft beobachtete Handlungen und Maße. Die rechtliche Entscheidung über Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit bleibt dem Gericht vorbehalten.

6 Anlagen

K 1 Ausgangsbescheid vom 10. Juni. K 2 Widerspruch vom 17. Juni mit Eingangsvermerk. K 3 Widerspruchsbescheid und Zustellnachweis vom 26. Juni. K 4 Überweisung und ärztliche Verordnung. K 5 Facharztbericht vom 17. Mai. K 6 Eigenschilderung zu Alltag und Wegen. K 7 Wohnumfeldbericht und Begehungsprotokoll vom 9. Juni. K 8 Angebot vom 20. Mai und Erprobungsnotiz vom 18. Mai. K 9 Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 5. Juni. K 10 privater Funktionsbericht vom 18. Juni. K 11 Nachricht der Tochter vom 27. Juni.

Joost Ahlers · Rechtsanwalt

An das Sozialgericht Oldenburg
Schlosswall 16 · 26122 Oldenburg
22. Juli 2026 · S 12 KR 188/26 · HM-2026-7714-E-K

Klageerwiderung

In der Sache Heinz Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse beantragen wir, die Klage abzuweisen.

1 Umfang des Streits

Zwischen den Beteiligten steht außer Frage, dass der Kläger versichert ist und dass seine Fortbewegung erheblich beeinträchtigt ist. Zu entscheiden ist, ob die bezeichnete elektrische Versorgung bereits auf Grundlage der festgestellten Funktionslage notwendig ist. Die Erwiderung betrifft den Hilfsmittelantrag vom 22. Mai 2026. Eine Kostenübernahme für einen Umbau wurde nicht beantragt. Ein leistungsfähiges Modell aus dem Bestand würde bei gegebener Eignung in Betracht kommen. Einen Anspruch auf die Anschaffung eines Neugeräts erkennen wir auf dieser Grundlage nicht an.

Der Klageantrag benennt eine rechtsseitige Bedienung, einen angepassten Sitz, Licht, Kippschutz und Einweisung. Die Beklagte versteht ihn als Anspruch auf eine funktionsbezogen bestimmte Versorgung. Soweit der Kläger alle Positionen des Kostenvoranschlags einklagen sollte, ist der Antrag entsprechend klarzustellen. Die Gründe für die medizinische Erforderlichkeit der einzelnen Positionen sind bisher unterschiedlich gut dokumentiert.

2 Tatsächliche Feststellungen und offene Punkte

2.1 Gehfähigkeit und Belastungsgrenzen

Die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes hat die fachärztlich beobachtete Strecke von 32 Metern unter Aufsicht berücksichtigt. Die Beklagte behauptet nicht, dass damit schon der Weg zur Apotheke bewältigt werden kann. Für die Bewertung der Alternativen ist jedoch von Bedeutung, dass Transfers und kurze ebene Teilstrecken mit vorhandenen Hilfsmitteln möglich bleiben. Aus den Unterlagen ergeben sich einzelne brauchbare Teilfunktionen, etwa Aufstehen mit Armlehne und Bewegung bis zu einem nahen Haltepunkt. Welche Tätigkeiten mit einer Gerätekombination regelmäßig und ohne erhebliche Hilfe durchführbar wären, wurde bislang nicht unter gleichen Bedingungen geprüft.

Nach dem privaten Bericht konnte der Kläger den gewöhnlichen Faltrollstuhl im Hof nicht ohne Lenkabweichung und Beschwerden bewegen. Der Befund ist zu berücksichtigen. Angaben zu Greifreifenposition und individueller Einstellung fehlen. Ein individuell angepasster leichter Aktivrollstuhl könnte leichter anzutreiben sein. Die Beklagte macht diese Möglichkeit geltend, ohne eine abgeschlossene Erprobung behaupten zu können. Bei der Untersuchung sollten auch Greiffähigkeit beider Hände, Beschwerden nach wiederholter Belastung, der Einfluss der Schulterstellung und die Möglichkeit zum kontrollierten Anhalten erhoben werden.

2.2 Nutzung ab Erdgeschoss

Die Eignung des elektrischen Geräts im Hof setzt voraus, dass der Kläger sich regelmäßig zum Gerät begeben kann. Die Fotos erklären die örtliche Lage, belegen aber keine Zustimmung zur Abstellung oder zum Laden. Die Hausverwaltung nennt einen Trockenraum und verlangt eine elektrische Prüfung. Der frühere Vorschlag, das Gerät im Flur zu lassen, ist nach deren Angaben wegen des Rettungswegs nicht nutzbar. Auch bleibt offen, ob die rückwärtige Tür aus dem Sitz ohne Hilfe geöffnet werden kann. Der private Test fand mit gehaltenem Türflügel statt. Die Beklagte bittet um Klärung, ob und zu welchen Bedingungen der Raum für den Kläger inzwischen verfügbar ist.

Die Hilfe beim Treppenweg und die Begleitung während aller Erledigungen sind unterschiedliche Fragen. Sofern die Tochter den Kläger regelmäßig ins Erdgeschoss und wieder hinauf begleiten könnte, kann ein eigener Weg ab Erdgeschoss einen praktischen Zugewinn darstellen. Wenn die Begleitmöglichkeit unregelmäßig bleibt und der Transportweg zur Straße nur mit Hilfe an der Tür funktioniert, kann eine elektrische Versorgung trotz positiver Hofprobe im Alltag nur eingeschränkt wirken. Zu beurteilen ist die tatsächliche Häufigkeit, nicht die theoretische Bereitschaft von Angehörigen. Wir bitten, Zeugin Maren Körner zu den konkreten Zeiten und zur Dauer des Einsatzes zu hören.

2.3 Vergleichsangebote

Der Vertragspreis des Standard-Faltrollstuhls liegt bei ungefähr 740 Euro. Dieses Angebot wurde als mögliche Erstversorgung zur praktischen Prüfung genannt. Es ist noch kein Nachweis einer gleich wirksamen Versorgung im Einzelfall. Für die weitere Prüfung wird die Beklagte den Leistungserbringer um die konkreten Maße sowie um Angaben zu Anpassungsoptionen bitten. Wir halten es für sinnvoll, den vorhandenen Faltstuhl und ein individuell einstellbares Gerät in vergleichbaren Versuchen zu prüfen. Dabei sollten Länge, Hindernisse, die Art der Hilfe und die Belastung beim Rückweg dokumentiert werden.

Das Angebot über 10.990 Euro umfasst Zubehör und Einweisung. Soweit das Gerät aufgrund rechtsseitiger Steuerung und geeigneter Sitzanpassung eine belastbare Funktion ermöglicht, wären diese Bestandteile grundsätzlich in die Kostenbetrachtung einzubeziehen. Die medizinische Notwendigkeit eines gesonderten Bordsteinassistenten oder zusätzlicher Reichweitenreserven hängt von der örtlichen Strecke und der konkreten Ausführung ab. Ein Standardpreis oder ein Listenplatz beantwortet diese Fragen jeweils nur teilweise.

3 Rechtlicher Maßstab

Die Beklagte geht wie der Kläger davon aus, dass Paragraf 33 Absatz 1 SGB V einen Anspruch auf bedarfsgerechten Behinderungsausgleich im Nahbereich eröffnen kann. Die verbleibende Gehstrecke ist ein Teil der funktionellen Prüfung. Ein abstraktes Erfordernis vollständiger Gehunfähigkeit leiten wir aus dem Gesetz nicht ab. Streit besteht über das Ausmaß der zu erwartenden Verbesserung durch die verlangte Versorgung und darüber, welche Alternativen diese Funktion ebenfalls erreichen.

Die Urteile des Bundessozialgerichts vom 18. April 2024, B 3 KR 13/22 R und B 3 KR 14/23 R, betreffen motorunterstützte Zuggeräte. Ihre Aussagen zur Einzelfallbezogenheit des Nahbereichs und zum Vergleich tatsächlich geeigneter Alternativen sind für die vorliegende Prüfung bedeutsam. Das Gericht hat in den jeweiligen Fällen von den festgestellten konkreten Gebrauchsvorteilen aus entschieden. Die Entscheidungen enthalten keine unmittelbare Aussage zur Bedienbarkeit des hier angebotenen Geräts, zur tatsächlichen Wegstrecke im Oldenburger Wohnumfeld oder zur sicheren Lagerung. Die gerichtliche Tatsachenerhebung bleibt daher erforderlich.

Paragraf 12 SGB V gewinnt Bedeutung, sobald konkrete Alternativen mit im Wesentlichen gleichwertiger Funktion vorliegen. Die Beklagte hält eine günstigere Versorgung weiterhin für prüfbar. Ein hoher Preis allein beantwortet weder den Anspruch dem Grunde nach noch die Frage der erforderlichen Ausführung. Sollte sich eine elektrisch gesteuerte Versorgung nach Aufklärung als erforderlich herausstellen, regen wir an, die konkrete Bewilligung auf nachgewiesene Funktionen zu beziehen und ein geeignetes Wiedereinsatzgerät sowie gegebenenfalls eine leihweise Versorgung nach Paragraf 33 Absatz 5 SGB V zu prüfen.

3.1 Nutzen einzelner Wege und notwendige Geräteausstattung

Die Entfernungen in der Eigenschilderung sind bislang Schätzwerte. Die Beklagte regt an, ab Erdgeschoss und ab Wohnung getrennt zu messen. Eine Messung sollte den üblichen Rückweg und den Zugang zum jeweiligen Geschäft enthalten. Ob ein Arztbesuch mit dem angebotenen Fahrzeug eigenständig gelingt, hängt neben der Ausdauer von der Erreichbarkeit des Eingangs, der Platzsituation vor der Tür und der Möglichkeit ab, den Rollstuhl am Ziel sicher abzustellen. Eine Hilfeleistung im Haus kann mit eigenständigem Fahren im übrigen Teil des Wegs vereinbar sein. Nach den vorliegenden Angaben lässt sich ihr tatsächlicher Umfang noch nicht abschätzen.

Die Beklagte hat in der Verwaltungsentscheidung auf vorhandene Liefer- und Transportmöglichkeiten verwiesen. Bei einer Apotheke können diese eine konkrete Versorgungslücke mindern. Sie ersetzen nicht ohne Weiteres die eigenständige Wahrnehmung anderer gewöhnlicher Wege. Ihre Bedeutung sollte anhand der realen Verfügbarkeit festgestellt werden. Das gilt ebenso für die Mitnahme durch die Tochter. Ein einmaliger Transport ist aus Sicht der Beklagten ein Hinweis auf eine mögliche Teilhilfe und kein Nachweis durchgängiger Versorgung.

3.2 Ablauf eines Vergleichsangebots

Für eine Erprobung sollte der Anbieter die Maße der Vergleichsgeräte, den Greifreifenabstand, den tatsächlichen Wenderaum, die Bedienkräfte und den Bedarf an Zubehör angeben. Ein günstigerer Standard-Elektrorollstuhl könnte bei geeigneter Sitz- und Steuerungsmöglichkeit in Betracht kommen. Dazu fehlen bisher ein verbindlicher Preis für das angepasste Gerät und ein Versuch mit vergleichbarer Strecke. Der Anbieter sollte auch erläutern, ob ein Zusatzantrieb unmittelbar durch den Kläger steuerbar ist oder nur einer Begleitperson dient. Beide Varianten dürfen in der Prüfung nicht als gleiche Leistung behandelt werden.

Bei Geräten mit nachgewiesenem Vorteil kommen zwei Abgabeschritte in Betracht. Zunächst werden die technische Anpassung, die Lagermöglichkeit und die Einweisung vorbereitet. Anschließend wird eine realistische Alltagsstrecke erprobt, bevor der Kläger das Gerät für den selbstständigen Gebrauch übernimmt. Ein Versorgungsangebot kann für diesen Schritt eine niedrige Geschwindigkeitsstufe und eine Nachkontrolle vorsehen. Die Beklagte wird nach Eingang eines verlässlichen Berichts prüfen, ob sie ein solches Angebot vorlegen kann. Der Leistungsantrag bleibt nach dem gegenwärtigen Aktenstand streitig.

4 Beweis und weiteres Vorgehen

Die Verwaltungsakte wird vollständig vorgelegt. Wir regen die rehabilitationsmedizinische Untersuchung unter definierten Bedingungen an. Benötigt werden Aussagen zur Rollatornutzung unter Aufsicht und ohne Eingriff, zum manuellen Antrieb bei angepasster Sitzposition, zu Schmerz- und Erschöpfungsverlauf und zur Bedienung eines gedrosselten Elektrorollstuhls. Der Sachverständigen sollten der ursprüngliche Kostenvoranschlag, das Vertragsangebot und die Ortsmessungen vorliegen. Ein ergänzender Ortstermin erscheint sinnvoll, wenn die allgemeine Fahreignung bejaht wird und die Eignung von Tür und Stellplatz streitig bleibt.

Die Beklagte ist zur Mitwirkung an einer begleiteten Erprobung bereit. Ein Versorgungsvorschlag nach dem Ergebnis der Prüfung bleibt möglich. Bis dahin hält sie den Klageabweisungsantrag aufrecht.

Dr. Hannah Brömmer · Justitiariat

Beweisbeschluss

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Schlosswall 16, 26122 Oldenburg

Aktenzeichen: S 12 KR 188/26

Oldenburg, den 05.08.2026

In dem Rechtsstreit Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse beschließt die Kammer:

Beschluss

1. Es wird gemäß Paragraf 106 SGG Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens.

2. Zum Sachverständigen wird bestimmt: Prof. Dr. med. Anneliese Wickenrath, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Bremen.

Beweisfragen

1. Welche Wegstrecke kann der Kläger nach dem gegenwärtigen Gesundheitszustand mit einem Rollator sicher und ohne relevantes Sturzrisiko zurücklegen?

2. Ist der Kläger in der Lage, einen manuellen Aktivrollstuhl über einen Nahbereich von mindestens 500 Metern selbständig anzutreiben, insbesondere unter Berücksichtigung der Schulterbeschwerden?

3. Besteht bei Nutzung eines Standard-Faltrollstuhls ohne Begleitperson eine ausreichende Sicherheit gegen Sturz und Unterzuckerungsfolgen?

4. Ist der Kläger unter Berücksichtigung von Sehvermögen, Reaktionsvermögen und Sensibilitätsstörungen in der Lage, einen Elektrorollstuhl mit gedrosselter Geschwindigkeit sicher zu führen?

5. Welche Auswirkungen hat die jeweilige Versorgung auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinne des Basisausgleichs?

Hinweis an die Beteiligten

Den Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen ergänzende Fragen an den Sachverständigen zu stellen. Der Sachverständigen wird die vollständige Verwaltungsakte einschließlich der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes und des privaten Reha-Gutachtens übersandt.

An das Sozialgericht Oldenburg · 12. Kammer
Schlosswall 16 · 26122 Oldenburg
16. September 2026 · Aktenzeichen S 12 KR 188/26

Rehabilitationsmedizinisches Sachverständigengutachten

1 Auftrag und Grundlagen

Auf den Beweisbeschluss vom 5. August 2026 habe ich Herrn Heinz Körner am 2. September in Bremen persönlich untersucht. Beurteilt wurden Gehfähigkeit, manueller Antrieb, Handhabung eines kompakten elektrisch gesteuerten Rollstuhls und die daraus ableitbaren Funktionen. Das Gutachten beruht auf der Gerichtsakte, der beigezogenen Verwaltungsakte sowie der Untersuchung und den unten beschriebenen Versuchen. Der Hauszugang wurde von mir nicht persönlich besichtigt. Angaben hierzu stammen aus der Begehungsnotiz der Hausverwaltung, den Fotos und den Angaben des Klägers. Eine abschließende rechtliche Beurteilung der Leistungsvoraussetzungen ist nicht Gegenstand des Auftrags.

Die Untersuchung begann um 9.10 Uhr. Der Kläger erschien mit seiner Tochter. Er trug feste Schuhe und brachte den eigenen Rollator mit. Vor den Geh- und Fahrproben wurden Risiken und Abbruchbedingungen erläutert. Nach jeweils einem Versuch hatte er Gelegenheit zur Erholung im Sitzen. Ich lasse die geschätzten Entfernungen im Wohnumfeld bei der Befunddarstellung von den im Klinikflur gemessenen Strecken getrennt.

2 Relevante Fremdbefunde

Die hausärztliche Verordnung vom 16. Mai beschreibt unter anderem eine Stenose der Lendenwirbelsäule, eine diabetische Polyneuropathie, eine linke Hüfttotalendoprothese und kardiale Belastungsgrenzen. Der Facharzt dokumentiert am 17. Mai einen Abbruch nach 14 Metern mit Unterarmgehstütze und eine beaufsichtigte Strecke von 32 Metern mit Rollator auf ebener Fläche. Die physiotherapeutische Behandlung ist über einen längeren Zeitraum belegt. Aus dem Verlaufsbericht ergibt sich keine deutlich zunehmende Gehstrecke trotz fortlaufender Übung. Die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 5. Juni stützt sich auf die ihm vorgelegten Schriftstücke und geht von vorhandener Restmobilität aus.

Der Bericht von Herrn Falke vom 18. Juni dokumentiert nach persönlicher Beobachtung einen Abbruch an der Bordsteinkante mit Rollator sowie Schwierigkeiten mit einem einfachen Faltrollstuhl. Er beschreibt die erfolgreiche Bedienung des rechtsseitigen Joysticks im Innenhof und die erforderliche Hilfe beim Öffnen der Hintertür. Das ergänzende Begehungsprotokoll der Hausverwaltung weist darauf hin, dass die zuerst ins Auge gefasste Flurnische ein Rettungsweg ist und der Nebenraum derzeit nur als Möglichkeit vorgesehen ist. Ich habe keine verbindliche Freigabe des Stromanschlusses in der Akte gefunden.

3 Anamnese und klinischer Befund

3.1 Eigenanamnese

Der Kläger beschreibt ein pelziges Gefühl beider Fußsohlen und zunehmende Unsicherheit, wenn er die Füße nicht sehen kann. Beim längeren Stehen tritt Schwindel auf. Die rechte Schulter schmerzt besonders bei nach hinten reichender Armbewegung und beim kräftigen Ziehen. Der Kläger berichtet, dass die Beschwerden schwanken und nach manchen Tagen mit Arzttermin noch am Abend stärker sind. Er benannte Hausarzt und Apotheke als wichtigste derzeit nicht selbstständig bewältigte Wege. Zuletzt habe die Tochter die Arzneimittel abgeholt.

Der Kläger konnte das Ereignis vor der Apotheke im Mai schildern. Zu den genauen Bedingungen der einzelnen Stürze liegen überwiegend Eigenangaben und Mitteilungen der Familie vor. Aus der bei mir vorliegenden Dokumentation lässt sich weder für jedes Ereignis die Ursache bestimmen noch eine Unterzuckerung als gemeinsame Ursache belegen. Die Dauermedikation wurde gesichtet. Die Fahrsicherheitsbeurteilung erfasst den aktuellen Untersuchungstag und ersetzt keine gesonderte ärztliche Beurteilung möglicher wechselnder Stoffwechselzustände.

3.2 Körperliche Untersuchung

Der Kläger war wach, zeitlich und örtlich orientiert und konnte die nacheinander erläuterten Aufgaben in richtiger Reihenfolge wiedergeben. Das Sehen mit eigener Brille reichte im Untersuchungsraum aus, um Markierungen und Hindernisse zu erkennen. Eine fachaugenärztliche Untersuchung wurde nicht vorgenommen. Im Sitzen konnte er den Rumpf über kurze Zeit stabil halten. Beim Aufstehen benötigte er die Armlehnen und stellte die Füße vor der ersten Bewegung mehrfach neu.

Die Sensibilität für leichte Berührung war an beiden Fußsohlen distal vermindert. Die Vibrationsempfindung an den Innenknöcheln war deutlich reduziert. Die aktive Hüftbeugung links und die Fußheberkraft beidseits waren eingeschränkt. Der Kläger schwankte bereits im freien Stand mit offenen Augen. Bei der vorsichtigen Prüfung mit engerer Fußstellung musste ich die Sicherung verstärken. Eine Prüfung mit geschlossenen Augen wurde wegen der deutlichen Fallneigung nicht fortgeführt.

Die rechte Schulter war bei Abduktion und Rückwärtsführung schmerzhaft eingeschränkt. Die linke Hand konnte den Greifreifen bei passender Sitzhöhe grundsätzlich umfassen. Die Greiffolge war verlangsamt. Der Kläger hatte im Sitzen ausreichend selektive Bewegung der rechten Hand, um einen leichten Joystick in verschiedene Richtungen zu bedienen. Die kontinuierliche Belastung beim manuellen Antrieb ist mit dieser kleinräumigen Handbewegung funktionell nicht vergleichbar.

4 Versuche unter definierten Bedingungen

4.1 Gehen mit Rollator

Die Strecke verlief im trockenen ebenen Klinikflur und war mit Markierungen in Abständen von zehn Metern versehen. Die Sicherung ging nebenher, ohne an den ersten beiden Markierungen eingreifen zu müssen. Nach etwa 30 Metern wurde das Tempo geringer. Bei 40 Metern gab der Kläger Schwindel und Erschöpfung an. Ich brach die Prüfung ab und ließ ihn auf einem Stuhl Platz nehmen. Eine Wendung mit Fortsetzung des Wegs über weitere 40 Meter fand nicht statt. Das Ergebnis bezeichnet eine einmalige Leistung unter günstigen Bedingungen und keine ausdauernd verfügbare Gehstrecke.

4.2 Manueller Aktivrollstuhl

Der für die Untersuchung bereitgestellte Aktivrollstuhl war in der Sitzbreite passend eingestellt. Die Greifreifen waren beidseits erreichbar. Auf dem ersten geraden Flurabschnitt fuhr der Kläger langsam, setzte den linken Arm mehrfach verspätet ein und korrigierte rechts. Nach etwa 30 Metern berichtete er deutliche Ermüdung beider Schultern und Schmerzen rechts. Die Rückfahrt erfolgte geschoben. Ein Teil der Schwierigkeiten im vorangegangenen Faltstuhlversuch beruht vermutlich auf Gerätepassung und höherem Rollwiderstand. Die Beschwerden in der angepassten Ausführung zeigen jedoch, dass die Armfunktion auch bei besserer mechanischer Ausgangslage für regelmäßig wiederholte Außenwege begrenzt bleibt.

Beim Versuch wurde weder ein standardisierter Einhandantrieb noch ein motorisierter Zusatzantrieb eingesetzt. Ein elektrisch steuerbares System mit geeigneter Bedienung könnte die Schulterbelastung ebenfalls vermindern. Dazu fehlen die konkrete Kombination aus Fahrgestell und Steuerung, Maße am

Einsatzort sowie eine tatsächliche Vergleichserprobung. Der Fall lässt deshalb keine medizinische Aussage zu allen auf dem Markt verfügbaren Alternativen zu.

4.3 Elektrische Steuerung

Die Geschwindigkeit war auf Schrittgeschwindigkeit begrenzt. Nach Erklärung der Bedienelemente absolvierte der Kläger Geradeausfahrt, zwei Kurven, eine Wendung und drei Bremsvorgänge an der Markierung. Beim ersten Rückwärtsansetzen an die markierte Fläche setzte er zu spät gegen und hielt nach eigener Korrektur erneut an. Bei Wiederholung gelang die Einfahrt mit größerem seitlichem Abstand. Die rechte Hand blieb auf der eingestellten Auflage. Mit diesem Setup und ohne gleichzeitige Belastung durch Türöffnung konnte der Kläger das Gerät steuern. Eine öffentliche Fahrstrecke, nasses Pflaster und die gleichzeitige Bedienung von Tür und Joystick wurden nicht erprobt.

5 Beantwortung der Beweisfragen

5.1 Sichere Gehstrecke mit Rollator

Im Untersuchungsgang legte der Kläger etwa 40 Meter auf glatter Ebene unter Aufsicht zurück. Danach war ein Abbruch erforderlich. Die niedrigeren Strecken in früheren Berichten sind bei Unterschieden in Untergrund und Belastung plausibel. Für einen täglichen Weg von mehreren hundert Metern mit Rückweg, Bordsteinkanten und Türbedienung ergibt sich aus keiner Probe eine sichere und belastbare Leistungsfähigkeit.

5.2 Eigenantrieb eines manuellen Rollstuhls

Mit angepasstem Aktivrollstuhl erreichte der Kläger etwa 30 Meter im ebenen Flur. Der Armgebrauch war asymmetrisch, und die rechte Schulter wurde durch wiederholte Korrektur belastet. Ein selbstständiger Weg von 500 Metern ist mit der untersuchten Ausführung nach den Beobachtungen nicht realistisch. Diese Distanz beantwortet die konkrete Beweisfrage und ist keine medizinische Mindestanforderung für jeden Nahbereich. Bereits deutlich kürzere Wege mit Türöffnung und Rückfahrt können die tatsächlich verfügbare Funktion überschreiten.

5.3 Sicherheit mit Standard-Faltrollstuhl

Bei reiner Begleitnutzung kann ein Faltrollstuhl als Sitz- und Transportmittel nützlich sein. Eine sichere selbstständige Bedienung mit gewöhnlichem beidhändigen Greifreifenantrieb ist bei den festgestellten Umständen nicht zu erwarten. Risiken ergeben sich aus Lenkabweichung, Ermüdung, Schmerzen und dem Umsetzen. Für die Annahme eines zusätzlichen spezifischen Unterzuckerungsrisikos während der Fahrt fehlt eine objektive Messreihe. Empfehlungen zum Umgang mit der Grunderkrankung sind mit der behandelnden Praxis abzustimmen.

5.4 Bedienung des Elektrorollstuhls

Der gedrosselte Elektrorollstuhl war unter den untersuchten Bedingungen mit rechtsseitiger Steuerung geeignet. Ich empfehle eine Anpassung von Handauflage und Sitz, eine dokumentierte Einweisung und eine Erprobung im tatsächlichen Gebäude- und Wegumfeld. Ein Versuch mit der Hoftür sollte zeigen, ob eine Türhilfe notwendig ist. Wiederholte Fahrfehler, vermehrter Schwindel, erhebliche Bedienunsicherheit bei wechselnder Aufmerksamkeit oder eine fehlende Möglichkeit zur sicheren Lagerung wären Anlass, die Nutzung unter den konkreten Bedingungen erneut zu beurteilen.

5.5 Praktischer Nutzen

Soweit der Kläger in das Erdgeschoss gelangen und den Abstellraum sowie den Hofzugang nutzen kann, eröffnet ein elektrisch betriebenes geeignetes Gerät eine eigenständige Fortbewegung auf

Strecken, für die die erprobten Gehhilfen und manuellen Geräte nicht ausreichen. Ob und in welchem Umfang dieser Gewinn regelmäßig eintritt, hängt zusätzlich von der tatsächlich verfügbaren Treppenhilfe ab. Eine tragfähige Lösung kann etwa in planbaren Begleitzeiten für den Treppenabschnitt bestehen. Aus dem Fahrversuch folgt keine eigenständige Überwindbarkeit der Treppe. Zur Regelmäßigkeit der Hilfe ist eine weitere Tatsachenklärung sinnvoll.

6 Schlussbemerkung

Die erhobenen Befunde erklären, warum die vorhandene Restgehfähigkeit, die mit Begleitung für eine kurze ebene Strecke ausreicht, nicht ohne Weiteres die Mobilität im Nahbereich trägt. Für den weiteren Vergleich sollten Versuche im Hof und auf einem kurzen typischen Alltagsweg in vergleichbarer Reihenfolge protokolliert werden. Die Dokumentation sollte Fahrhilfe, Türöffnung, Transfer und Rückweg getrennt ausweisen. Eine elektrische Lösung ist aus rehabilitationsmedizinischer Sicht ernsthaft geeignet. Der konkrete Versorgungsumfang und die Bedeutung noch offener Zugangsfragen bleiben anhand des tatsächlich erprobten Geräts zu bewerten.

Prof. Dr. med. Anneliese Wickenrath

An Heinz Körner und Maren Körner

Oldenburg, 9. Juni 2026

Theaterwall 62 · Begehung am 8. Juni 2026

Begehungsprotokoll Hauseingang und Ladeplatz

1 Weg von der Wohnung ins Erdgeschoss

Bei der Begehung waren Herr Körner, seine Tochter, Frau Voss für RehaTechnik Albrecht und Hausmeister Ulf Bödeker anwesend. Ausgangspunkt war die Wohnung im ersten Obergeschoss. Der kürzeste Weg zum vorgesehenen Abstellplatz führt über die Bestandstreppe mit 15 Stufen. Herr Körner ging nur die ersten drei Stufen probeweise hinunter und wieder hinauf, rechts am Geländer und mit einer Person unterhalb. Einen vollständigen Treppengang haben wir an diesem Tag nicht durchgeführt.

Über den vorderen Hauseingang kommt man vom Bürgersteig über zwei Stufen in den Vorraum. Die beiden Stufen sind 14 und 16 Zentimeter hoch. Im Hochparterre befindet sich ein kleiner Plattformlift, der ausschließlich den dortigen Niveauversatz zum Hofsteg überwindet. Er fährt weder bis in die Wohnung noch unmittelbar auf den Bürgersteig. In der Beschreibung vom 18. Mai war er als Aufzug bezeichnet. Für eine Benutzung vom ersten Obergeschoss aus hilft er nicht.

2 Alternative über den Hof

Vom Abstellplatz im Erdgeschoss lässt sich der Innenhof ohne die vorderen Eingangsstufen erreichen. Die hintere Tür hat bei vollständig geöffnetem Flügel eine lichte Breite von 92 Zentimetern. Am Übergang zum Hof liegt eine 23 Millimeter hohe Metallschwelle. Von der befestigten Hoffläche führt eine gemessene Steigung von ungefähr 5 Prozent zur Straße. Bei Nässe wird das Pflaster unmittelbar unter dem Fallrohr rutschig. Die Hausverwaltung lässt die Undichtigkeit prüfen. Ein auf dem Foto sichtbarer Holzkeil ist nur zum Versuch hingelegt worden. Für den Dauerbetrieb ist die Befestigung einer geeigneten Schwellenhilfe gesondert abzustimmen.

Die Tür schließt nach dem Loslassen selbst. Herr Körner konnte sie bei der Begehung von außen mit der rechten Hand aufdrücken, wenn er stand und sich am Rahmen festhielt. Die Bedienung aus dem Sitz wurde an diesem Termin nicht geprüft. Für die Freigabe des Hofwegs wollen wir einen gemeinsamen Versuch am tatsächlichen Gerät. Dabei soll geprüft werden, ob sich der Flügel mit dem angebotenen Feststeller ohne Einschränkung des Brandschutzes offen halten lässt.

3 Abstellen und Laden

Die in der ersten Besprechung vorgeschlagene Nische im Flur ist Teil des Rettungswegs. Sie kommt als dauerhafter Abstell- und Ladeplatz nicht in Betracht. Der abschließbare frühere Wäschetrockenraum neben dem Hinterausgang steht leer. Er hat eine lichte Türbreite von 89 Zentimetern und innen Platz für ein Gerät bis 115 Zentimeter Länge. Der Hausmeister kann bis zur technischen Freigabe einen Zweitschlüssel bereitstellen. Ein fester Ladeplatz ist erst nach Prüfung von Stromkreis, Steckdose und Herstellerangaben möglich. Ein Verlängerungskabel über den Flur darf nicht verwendet werden.

4 Offene Abstimmung

Wir bitten das Sanitätshaus, Außenmaße, Ladegerät und empfohlenen Platzbedarf für das Rückwärtsfahren schriftlich mitzuteilen. Frau Körner klärt, wer ihren Vater regelmäßig bis zum Erdgeschoss begleiten kann. Ein Umbau der Treppe oder eine Zustimmung zum Einbau eines Treppenlifts ist mit diesem Protokoll nicht zugesagt. Nach Abschluss der elektrischen Prüfung und der Fahrprobe soll über eine befristete Nutzung des Nebenraums entschieden werden.

Gesa Lübben · Hausverwaltung Am Wall

Heinz Körner · WEK-418-77-920
Theaterwall 62 · 18. Mai 2026
Anja Voss, Rehafachberaterin

Erprobungsnotiz Hof und Hauseingang

1 Aufbau und Reihenfolge

Herr Körner kam mit seiner Tochter über die vordere Haustür in den Hof. Der Treppenweg aus der Wohnung wurde von mir nicht beobachtet. Zu Beginn war der Boden trocken. Die Tochter blieb als Sicherung erreichbar. Für die drei Versuche wurde derselbe Teil des Hofes benutzt, soweit die Gehhilfe beziehungsweise der Rollstuhl das erlaubte. Zwischen den Versuchen saß Herr Körner jeweils mehrere Minuten. Die Längen sind mit einem Maßband gemessen und bezeichnen einfache Strecken, keine Hin- und Rückwege.

Hilfsmittel und Strecke	Beobachtung	Hilfe und Abbruchgrund
Unterarmgehstütze, etwa 10 Meter	Rechts geführt. Im ersten Richtungswechsel kreuzte der linke Fuß den rechten.	Tochter stützte am Ellenbogen. Keine weitere Gehstrecke erhoben.
Eigener Rollator, 22 Meter eben	Geradeaus langsam, beim Wechsel vom Hofpflaster zur Türschiene unsicher.	Versuch vor der Schwelle beendet.
Standard-Faltrollstuhl, 12 Meter	Linke Seite blieb zurück. Deutliche Gegenlenkbewegung rechts.	Am Ende Schulterbeschwerden. Tochter schob das Gerät zurück.
Kompakter Elektrorollstuhl, Rundkurs 78 Meter	Rechtsseitige Joysticksteuerung. Dreimal dosiertes Anhalten, einmal nach Hinweis korrigiert.	Aufsicht im Hof. Rückwärtsfahrt vor seitlicher Berührung abgebrochen.

2 Was sich aus dem Termin ablesen lässt

Herr Körner benutzte den Elektrorollstuhl nach etwa 25 Minuten Erklärung und Einweisung. Der sichere Geradeauslauf und die Bremsproben waren im Hof möglich. Die volle Fahrstrecke zum Hausarzt wurde nicht absolviert. Eine Straßenquerung fand nicht statt. Die Rückwärtsfahrt im engen Bereich musste die Fachberaterin mit einem Hinweis unterbrechen. Bei der nächsten Einweisung sollte das Fahrzeug niedriger eingestellt, die Stellung der Handauflage geprüft und der Rückweg aus dem Abstellraum geübt werden.

Der mitgebrachte Faltrollstuhl war ein einfaches Standardmodell ohne Kraftunterstützung. Die Beobachtung lässt noch keine Aussage über jede andere manuelle Versorgung zu. Für einen sinnvollen Vergleich wäre ein Modell mit angepasster Sitzbreite und erreichbaren Greifreifen erforderlich. Das Sanitätshaus hält ein solches Vergleichsgerät zur Zeit nicht im Hofbestand vor.

3 Aufgaben vor einer Bestellung

Die Tochter klärt den Ladeplatz mit der Hausverwaltung. Der schriftliche Kostenvoranschlag soll die angebotene Sitzanpassung, den Umfang der Einweisung, die technischen Voraussetzungen der Schwellenbewältigung und die voraussichtlichen Kosten der nächsten Wartung aufführen. Herr Körner bat darum, die Bedingungen eines Wiedereinsatzgeräts ebenfalls zu erfragen.

Anja Voss · Rehafachberaterin

Datei: csv/fristen_koerner.csv

Vorgang	Datum	Zugang	Fristende	Status
Ausgangsbescheid	10.06.2026	12.06.2026	13.07.2026	Widerspruch am 20.06.2026 eingegangen
Widerspruchsbescheid	24.06.2026	26.06.2026	27.07.2026	Klagefrist offen
Mandatierung	29.06.2026	29.06.2026	03.07.2026	Klage und Eilantrag entscheiden
MD-Akte anfordern	29.06.2026		03.07.2026	offen
Facharzt-Ergänzung	29.06.2026		10.07.2026	offen

Datei: csv/hilfsmittelvergleich.csv

Hilfsmittel	Kosten	Selbstständige Nutzung	Nahbereich	Gegenargument
Unterarmgehstütze	45 EUR	nein	nein	Sturzgefahr und Sensibilitätsstörung
Rollator vorhanden	0 EUR	teilweise	nein	Bordsteine Schwellen Gehweg nicht sicher
Standard-Faltrollstuhl	740 EUR	nein	teilweise	Nutzung nur mit Begleitperson
Elektromobil	4200 EUR	unklar	teilweise	zu großer Wendekreis und Abstellproblem
Elektrorollstuhl kompakt	10990 EUR	ja	ja	Fahrsicherheit durch Training absichern

Datei: csv/sturzprotokoll_koerner.csv

Datum	Ort	Hergang	Folge
14.02.2026	Badezimmer Wohnung	Ausrutschen beim Aufstehen von der Toilette	Prellung Hüfte links, kein Arztbesuch
02.04.2026	Küche Wohnung	Stolpern über Teppichkante	leichte Schürfwunde am Unterarm
03.05.2026	Gehweg vor Apotheke Peterstraße	Stolpern über abgesenkten Bordstein	Sturz mit Schürfwunden, Herbeirufen der Tochter

Datei: emails/2026-06-12_tochter_eingang_brief.eml

Von	Maren Körner <maren@koerner-familie.example>
An	Joost Ahlers <joost.ahlers@kanzlei-ahlers.example>
Datum	Fri, 12 Jun 2026 16:37:00 +0200
Betreff	Brief der Krankenkasse und Papiere aus dem Ordner

Sehr geehrter Herr Ahlers,

ich habe heute um kurz nach drei den Brief der Weser-Ems Gesundheitskasse aus dem Kasten meines Vaters geholt. Auf der ersten Seite stehen der 10. Juni und die Nummer HM-2026-7714-E. Den Umschlag hat mein Vater in das hintere Fach seiner roten Mappe gesteckt. Ich habe ihn gebeten, ihn dort zu lassen. Ich kann Ihnen heute nur die Kopie des Schreibens geben. Den Umschlag und den Originalbrief kann ich morgen mitbringen.

Mein Vater hat mir erlaubt, Ihnen die ärztlichen Berichte weiterzugeben. Er möchte selber mit Ihnen sprechen. Er hat seit gestern wieder gefragt, ob ihn jemand zur Apotheke mitnehmen kann. Ich arbeite am Wochenende bis 16 Uhr und kann ihn allenfalls abends von der Wohnung zum Hof begleiten. Die Hausverwaltung hat uns dort den früheren Trockenraum gezeigt. Wir haben noch keine Erlaubnis zum Laden. Für die Rückfahrt ins Haus muss die Tür aus der Sitzhöhe erreichbar sein. Das haben wir noch nicht versucht.

Bitte rufen Sie zunächst mich an und sagen Sie mir, welche Seiten fehlen. Ich reiche dann die Unterlagen nach, ohne dass mein Vater seine ganze Mappe abgeben muss.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Körner

Datei: emails/2026-06-27_tochter_an_kanzlei.eml

Von	"Dr. Maren Koerner" <maren.koerner@privatpost.de>
An	Kanzlei Ahlers und Brinkmann <kanzlei@privatpost.de>
Datum	Sat, 27 Jun 2026 18:42:00 +0200
Betreff	Unterlagen meines Vaters Heinz Körner

Sehr geehrter Herr Ahlers,

mein Vater hat gestern den Widerspruchsbescheid bekommen. Er war heute sehr aufgelöst, weil er nicht versteht, wie die Kasse sagen kann, dass ein Gehstock reicht.

Ich habe die Unterlagen angehängt beziehungsweise bringe sie am Montag mit:

- Bescheid vom 10.06.2026
- sein Widerspruch vom 20.06.2026
- Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026
- Verordnung und Bericht der Ärzte
- Reha-Gutachten Falke
- Kostenvoranschlag Sanitätshaus

Wichtig: Er ist am 03.05. vor der Apotheke gefallen. Seitdem geht er fast gar nicht mehr allein raus. Ich arbeite im Klinikum im Schichtdienst und kann nicht jeden Weg übernehmen. Es geht ihm nicht um Luxus, sondern darum, selbst zum Arzt und zur Apotheke zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Maren Körner

Datei: emails/2026-07-18_sachbearbeiterin_kanzlei_rueckfrage.eml

Von	Insa Bülow <insa.buelow@ahlers-brinkmann.de>
An	Joost Ahlers <j.ahlers@ahlers-brinkmann.de>
Kopie	Mara Eilers <m.eilers@ahlers-brinkmann.de>
Datum	Sat, 18 Jul 2026 09:15:00 +0200
Betreff	26-06-KR-1187 / Klagefrist, Zeugin und Anlagenstand Körner

Guten Morgen Herr Ahlers,

ich habe den Widerspruchsbescheid vom 24. Juni, den Eingangsstempel des Mandanten vom 26. Juni und den Briefumschlag abgeglichen. Bei Monatsfrist und Wochenendverschiebung komme ich auf Montag, 27. Juli 2026. Im elektronischen Kalender stehen Vorfrist 20. Juli und Endfrist 27. Juli; bitte geben Sie die Fristberechnung heute noch frei.

Der Klageentwurf enthält derzeit die Anlagen K1 bis K11. K4, der vollständige MD-Bericht, liegt nur als unvollständiger Scan mit fehlender Seite 6 vor. K8, die Fahrprobe des Sanitätshauses, nennt noch keine Uhrzeit und keine lichte Aufzugbreite. Ich habe beides nachgefordert. Der Widerspruchsbescheid soll K1 bleiben, damit die Geschäftsstelle den angegriffenen Verwaltungsakt sofort findet.

Frau Anna Körner hat telefonisch erklärt, dass sie zu Stürzen, ausgefallenen Arztwegen und der Erprobung im Sanitätshaus aussagen kann. Sie ist nicht Ärztin; im bisherigen Entwurf steht versehentlich Frau Dr. Körner. Bitte korrigieren. Ihre ladungsfähige Anschrift und die genauen Wahrnehmungsthemen liegen im Zeugenblatt.

Soll parallel mit der Klage ein Eilantrag hinausgehen, brauche ich bis Montag 10:00 Uhr die endgültige Auswahl der eidesstattlichen Versicherungen und die Freigabe der getrennten Anlagenfolge E1 bis E9.

Viele Grüße

Insa Bülow
Rechtsanwaltsfachangestellte
Kanzlei Ahlers und Brinkmann
Achternstraße 27 · 26122 Oldenburg
Telefon 0441 21874-12

Datei: emails/2026-09-23_tochter_an_kanzlei_nach_gutachten.eml

Von	"Dr. Maren Koerner" <maren.koerner@privatpost.de>
An	Joost Ahlers <j.ahlers@ahlers-brinkmann.de>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 21:17:00 +0200
Betreff	Nach dem Gutachten / Termin 22.10. (S 12 KR 188/26)

Sehr geehrter Herr Ahlers,

vielen Dank für die Übersendung des Gutachtens von Frau Prof. Wickenrath. Ich habe es meinem Vater am Sonntag vorgelesen, die 38 Seiten haben ihn ehrlich gesagt überfordert, aber er war froh, dass die Frau Professorin sich bei der Untersuchung so viel Zeit genommen hat und auch das Treppenhaus angeschaut hat.

Drei Dinge wollte ich Ihnen noch mitteilen:

1. Mein Vater ist am 19.09. abends in der Küche wieder gestürzt, diesmal beim Umdrehen am Herd. Er hat sich am Handrücken eine Platzwunde zugezogen, die Nachbarin Frau Eilts hat ein Pflaster draufgemacht, zum Arzt wollte er nicht. Ich habe es ins Sturzprotokoll eingetragen, soll ich Ihnen die aktualisierte Liste schicken? Das wäre dann der vierte Sturz dieses Jahr, oder der fünfte, ich müsste nachsehen.

2. Wegen dem Abstellplatz: ich hatte ja beim Vermieter (Hausverwaltung Renken) angefragt, ob ein Elektrorollstuhl im Hausflur hinten beim Hinterausgang abgestellt und geladen werden dürfte. Herr Renken hat jetzt am Telefon gesagt, grundsätzlich ja, er will aber eine schriftliche Vereinbarung wegen der Steckdose und dem Brandschutz. Brauchen Sie das für den Termin schriftlich?

3. Zum Termin am 22.10.: ich würde meinen Vater begleiten und habe mir den Tag freigenommen. Muss er persönlich erscheinen? Die Fahrt zum Gericht müssten wir organisieren, mit dem Rollator schafft er den Weg vom Parkplatz nicht, das ist ja fast ironisch.

Und noch eine Frage, die mein Vater mir aufgetragen hat: die Kasse hatte ihm ja im August dieses Standardmodell angeboten. Er will wissen, ob ihm das jetzt schaden kann, dass er das abgelehnt hat.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Körner

Datei: eml/2026-09-18_gutachterin_uebersendung.eml

Von	"Prof. Dr. Anneliese Wickenrath" <praxis@praxis-wickenrath.de>
An	Sozialgericht Oldenburg <poststelle@sg-oldenburg.de>
Kopie	Joost Ahlers <j.ahlers@ahlers-brinkmann.de>, Weser-Ems Gesundheitskasse <prozess@nordcare.de>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 14:02:00 +0200
Betreff	S 12 KR 188/26 / Gutachten Heinz Körner vom 16. September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Verfahren Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse übersende ich das aufgrund des Beweisbeschlusses vom 4. August 2026 erstellte Gutachten vom 16. September 2026 als PDF-Datei. Die Datei umfasst 38 Seiten einschließlich Literatur- und Anlagenverzeichnis; die Rechnung wird getrennt an die Justizkasse übermittelt.

Die persönliche Untersuchung fand am 2. September 2026 von 09:08 Uhr bis 11:46 Uhr in meiner barrierefrei zugänglichen Praxis statt. Anwesend waren Herr Körner, zeitweise seine Tochter Anna Körner und für die technische Erprobung Orthopädietechniker Sven Heuer. Verwendet wurden die im Gutachten bezeichneten Standard- und Elektrorollstühle. Messprotokolle, Fotografien der Anpassung und Einwilligungserklärungen sind als Anlagen G1 bis G6 beigefügt.

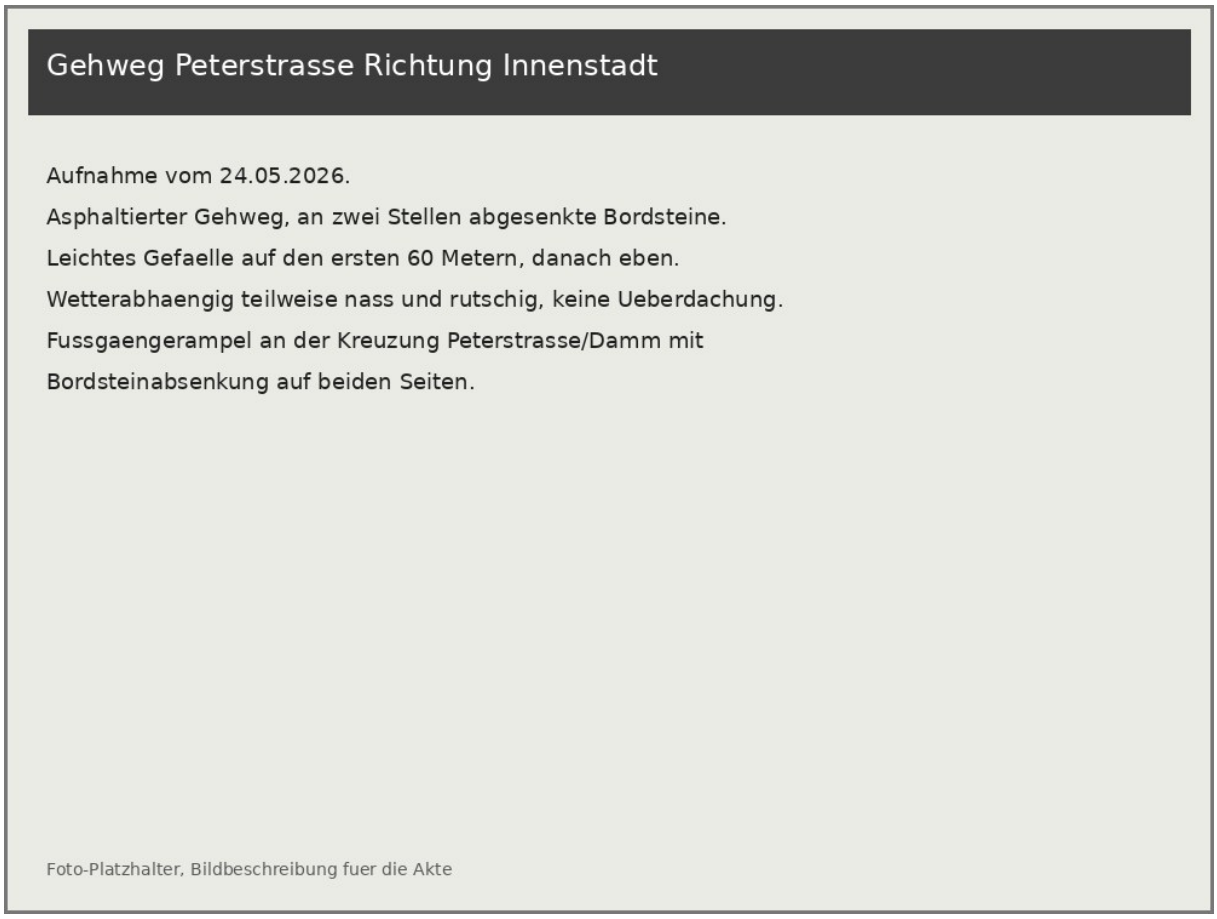
Herr Körner arbeitete kooperativ mit. Die Fahrproben wurden nach einer Einweisung durchgeführt; Pausen, Abbrüche und Hilfestellungen sind im Abschnitt 6 minutengenau dokumentiert. Eine rechtliche Bewertung oder Entscheidung über ein bestimmtes Fabrikat enthält das Gutachten nicht.

Bitte bestätigen Sie den lesbaren Eingang der Datei. Für schriftliche Ergänzungsfragen oder eine mündliche Erläuterung im Termin stehe ich nach gerichtlicher Anordnung zur Verfügung. Meine urlaubsbedingte Abwesenheit vom 5. bis 16. Oktober ist vorsorglich angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Anneliese Wickenrath
Fachärztin für Neurologie und Rehabilitationsmedizin
Gerichtsstraße 14 · 26122 Oldenburg
Telefon 0441 77018-0

Datei: jpg/gehweg_peterstrasse.jpg



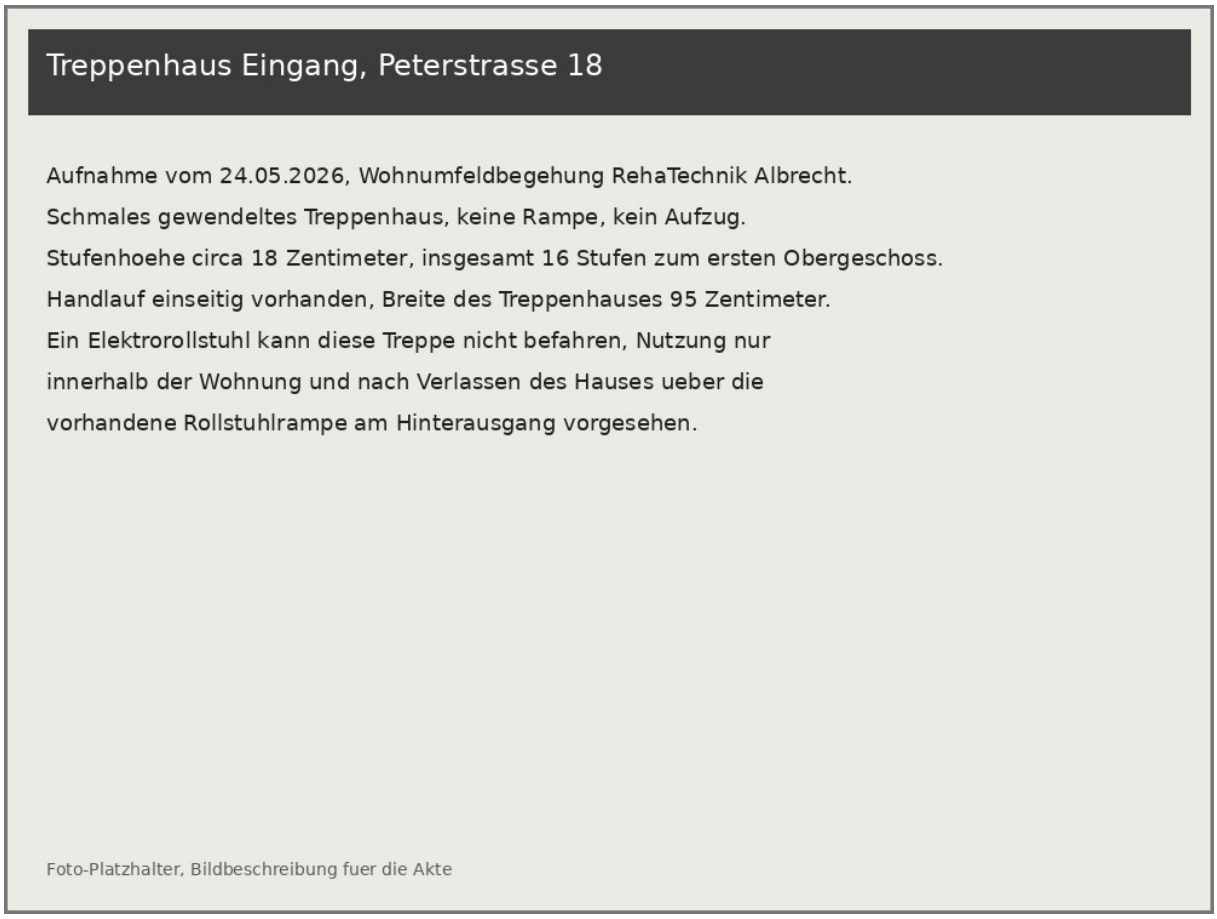
Bilddatei: gehweg_peterstrasse.jpg

Datei: jpg/hinterausgang_rampe.jpg



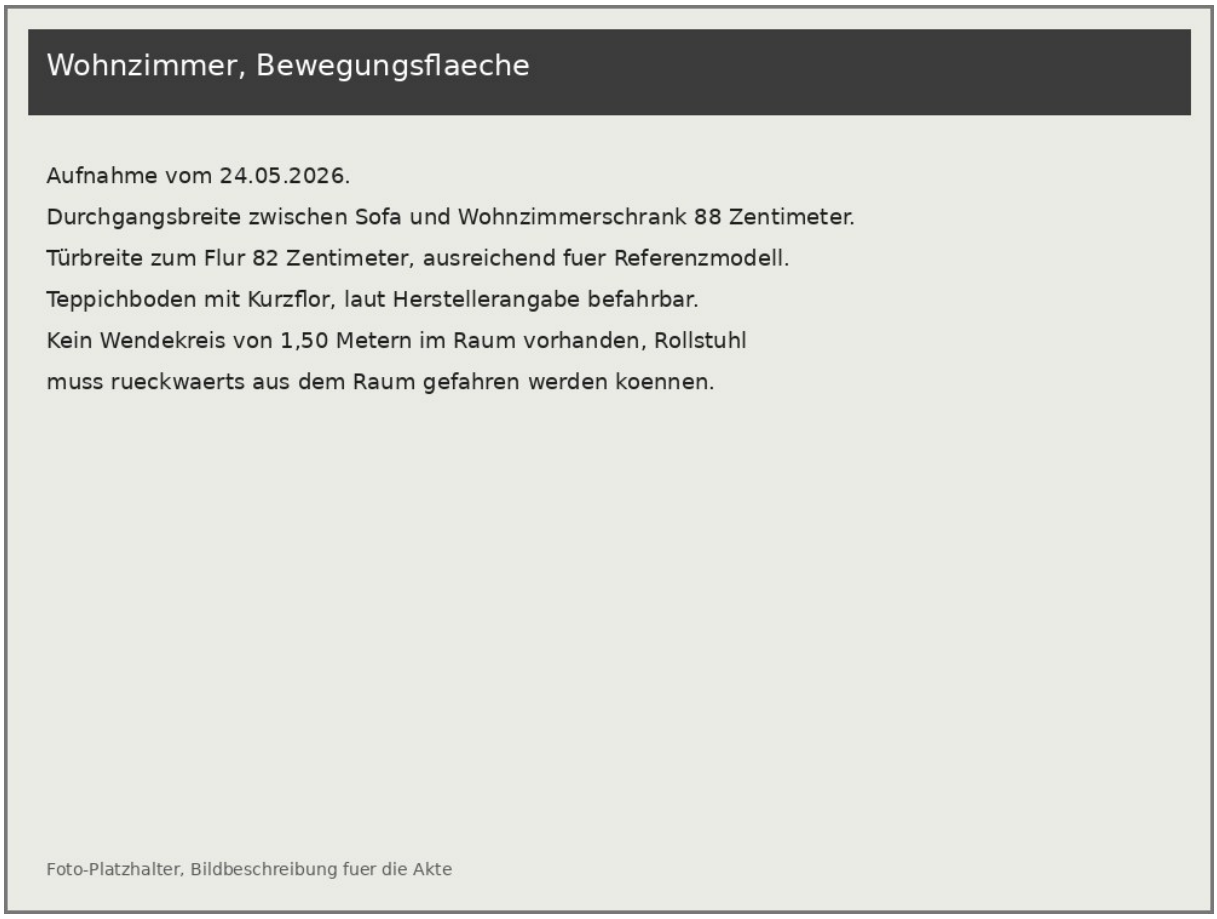
Bilddatei: hinterausgang_rampe.jpg

Datei: jpg/treppenhaus_altbau_eingang.jpg



Bilddatei: treppenhaus_altbau_eingang.jpg

Datei: jpg/wohnzimmer_bewegungsflaeche.jpg



Bilddatei: wohnzimmer_bewegungsflaeche.jpg

RehaTechnik Albrecht GmbH
Sanitätshaus und Rehatechnik
Nadorster Straße 145 · 26123 Oldenburg

Telefon 0441 887720
Telefax 0441 887729
service@rehatechnik-albrecht.de
www.rehatechnik-albrecht.de

Technisches Datenblatt

Elektrorollstuhl Compacta N6 - Innen- und Nahbereich

Dokumentnummer	RT-ER-26-0519	Ausgabedatum	20. Mai 2026
Bezug	Kostenvoranschlag KA-2026-1178	Versicherter	Dr. Walter Körner

1. Technische Ausführung

Merkmal	Ausführung Compacta N6
Abmessungen	Gesamtbreite 58 cm; Gesamtlänge 104 cm; Höhe der Rückenlehne 53 cm
Wendekreis	95 cm; erforderliche lichte Türbreite mindestens 80 cm
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit 6 km/h; Reichweite bis 25 km je Akkuladung
Antrieb und Batterie	Zwei 320-Watt-Motoren; zwei AGM-Batterien mit je 50 Ah; Ladegerät 8 A
Zuladung	Nutzergewicht bis 130 kg; Eigengewicht einschließlich Batterien 78 kg
Sitzsystem	Sitzbreite 46 cm; Sitztiefe 46 cm; Sitzhöhe von 45 bis 51 cm einstellbar
Rücken und Armlehnen	Rückenwinkel von 90 bis 120 Grad; hochschwenkbare, höhenverstellbare Armlehnen
Steuerung	Programmierbarer Joystick rechts; Bedienkraft und Beschleunigung individuell einstellbar
Sicherheit	Kippschutz, elektromagnetische Bremse, Beckengurt, Beleuchtung und Signalhorn
Transport	Sitz- und Antriebseinheit trennbar; schwerstes Einzelteil 42 kg; Verzurrpunkte gekennzeichnet

2. Vorgesehene Lieferkonfiguration

Für Herrn Dr. Körner ist die Joysticksteuerung rechts vorgesehen. Geliefert werden ferner ein abnehmbarer Beckengurt, winkelverstellbare Fußplatten, Kippschutzrollen, Stockhalter, Gelbatterie-Ladegerät und eine wetterfeste Abdeckhaube. Vor Übergabe werden Sitzhöhe, Armlehnen, Beschleunigung und Bremsverhalten in der Wohnung eingestellt.

3. Einsatzbereich und Grenzen

Das Modell ist für Innenräume sowie befestigte Wege im unmittelbaren Wohnumfeld bestimmt. Es bewältigt abgesenkte Bordsteine bis 5 cm und Steigungen bis 8 Prozent. Es ist nicht für Treppen, unbefestigte Waldwege, längere Überlandfahrten oder die Nutzung ohne vorherige Einweisung vorgesehen. Die Eignung im konkreten Wohnumfeld ist durch eine Probefahrt zu prüfen.

4. Übergabe, Einweisung und Service

Die Übergabe umfasst eine mindestens 60-minütige Einweisung, Brems- und Wendemanöver im Hausflur, das sichere Laden der Batterien sowie eine Probefahrt zum Briefkasten und zur nächsten abgesenkten Straßenquerung. Der mobile Kundendienst ist werktags von 08:00 bis 17:00 Uhr unter 0441 887720 erreichbar. Ersatzteile werden für mindestens acht Jahre vorgehalten.

Oldenburg, 20. Mai 2026 **i. A. Henrike Albrecht** · Reha-Fachberaterin und Ergotherapeutin Auftrag KA-2026-1178 / Position 1

Datum	Ereignis	Frist	Zuständig
12.05.2026	Antrag Elektrorollstuhl gestellt		Kläger
07.05.2026	Ärztliche Verordnung Dr. Stahlmann		Hausarzt
17.05.2026	Facharztbericht Dr. Radtke		Facharzt
20.05.2026	Kostenvoranschlag RehaTechnik Albrecht		Sanitätshaus
05.06.2026	MD-Stellungnahme Ablehnungsempfehlung		Medizinischer Dienst
10.06.2026	Ablehnungsbescheid		Kasse
18.06.2026	Privates Reha-Gutachten		RehaKompetenz Nordwest
20.06.2026	Widerspruch eingelegt	fristgerecht	Kläger
24.06.2026	Widerspruchsbescheid		Kasse
26.06.2026	Zustellung Widerspruchsbescheid	Klagefrist beginnt	Kläger
29.06.2026	Mandatierung Kanzlei Brammertz		Kläger
03.07.2026	Klageschrift gefertigt		Kanzlei
27.07.2026	Ende Klagefrist	letzter Tag	Kanzlei
22.07.2026	Klageerwiderung Kasse		Kasse
05.08.2026	Beweisbeschluss Sozialgericht		Sozialgericht Oldenburg
02.09.2026	Untersuchungstermin Sachverständige		Prof. Dr. Wickenrath
16.09.2026	Gutachten vorgelegt		Prof. Dr. Wickenrath
25.09.2026	Terminsverfügung		Sozialgericht Oldenburg
22.10.2026	Mündliche Verhandlung	10.30 Uhr, Saal 3	Sozialgericht Oldenburg

Hilfsmittel	Kosten in EUR	Förderfähig	Bemerkung
Unterarmgehstütze	45	ja	bereits vorhanden
Rollator	0	ja	bereits vorhanden
Standard-Faltrollstuhl	740	ja	bereits vorhanden
Elektromobil	4200	strittig	Wendekreis und Abstellproblem im Altbau
Elektrorollstuhl Basis	8990	beantragt	Hauptangebot Kostenvoranschlag
Elektrorollstuhl mit Sitzlift	10990	beantragt Alternative	Zusatzausstattung
Elektrorollstuhl Standardmodell Ka	6480	Gegenangebot Kasse	geringere Reichweite und Zuladung